



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PERAN EDUKASI DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN SELF EFIKASI IBU MELAKUKAN STIMULASI PERKEMBANGAN ANAK DENGAN STUNTING

Dorce Sisfiani Sarimin
Ni Luh Jayanthi Desyani
Yourisna Pasambo



PERAN EDUKASI DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN SELF EFIKASI IBU MELAKUKAN STIMULASI PERKEMBANGAN ANAK DENGAN STUNTING

Penulis:

Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.

Ni Luh Jayanthi Desyani, M.Kep., Ns., Sp.KMB.

Ns.Yourisna Pasambo, M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Peran Edukasi Dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap Dan Self Efikasi Ibu Melakukan Stimulasi Perkembangan Anak Dengan Stunting

Penulis: Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Ni. Luh Jayanthi Desyani, M.Kep., Ns., Sp.KMB.
Ns. Yourisna Pasambo, M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-59-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Peran edukasi dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan self efikasi ibu melakukan stimulasi perkembangan anak dengan stunting / Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An., Ni. Luh Jayanthi Desyani, M.Kep., Ns., Sp.KMB., Ns. Yourisna Pasambo, M.Kes.

Cetakan pertama, Februari 2025

Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

101 halaman ; 30 cm

ISBN 978-634-7097-59-0

Perkembangan anak -- Gizi anak -- Ibu dan anak - Pelayanan kesehatan
305.231 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1076574>

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan sehingga buku ini berjudul **'Peran Edukasi dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Self-Efikasi Ibu Melakukan Stimulasi Perkembangan Anak dengan Stunting'** dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian kami terhadap pentingnya peran edukasi dalam mendukung tumbuh kembang anak, khususnya pada anak yang mengalami stunting.

Peningkatan prevalensi stunting di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks ini, peran ibu sebagai pengasuh utama memiliki posisi yang sangat strategis. Melalui edukasi yang tepat, ibu dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan diri (self-efficacy) dalam memberikan stimulasi yang sesuai untuk mendukung perkembangan anak dengan stunting.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang mendalam, serta dilengkapi dengan berbagai teori dan pengalaman praktik di lapangan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi kesehatan, pemerintah, dan semua pihak yang peduli terhadap isu stunting dan upaya pencegahannya. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para ibu dan keluarga mengenai pentingnya stimulasi perkembangan anak

serta langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan dan penyelesaian buku ini.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 STIMULASI PERKEMBANGAN PADA ANAK STUNTING.....	5
---	----------

A. Perkembangan Anak	5
B. Stunting.....	6
C. Stimulasi Perkembangan Anak.....	10
D. Pemantauan Perkembangan Anak.....	14
E. Praktik Stimulasi Perkembangan Pada Anak Stunting	18
F. Praktik Teknik Pengasuhan Pada Anak Stunting	42

BAB 3 EDUKASI KESEHATAN	45
--------------------------------------	-----------

A. Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Ibu dengan Anak Stunting.....	45
B. Peran Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Edukasi	47
C. Pendekatan Holistik dalam Edukasi dan Stimulasi Anak Stunting.....	49
D. Metode Edukasi: Konseling, Penyuluhan, dan Media Digital	52

BAB 4 PENGETAHUAN, SIKAP DAN SELF AFIKASI	55
--	-----------

A. Pengetahuan.....	55
B. Sikap	59

<i>C. Self Efficacy</i>	61
-------------------------------	----

BAB 5 PENUTUP	67
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

GLOSARIUM	91
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	93
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Stunting adalah masalah tumbuh kembang terjadi pada anak-anak karena gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang kurang. Anak-anak balita dianggap stunting jika nilai z-score mereka kurang dari -2.00 SD atau standar deviasi (stunted), atau kurang dari -3.00 SD (severly stunted) (Fatmaningrum et al. 2022; WHO 2015).

Populasi balita stunting di Indonesia paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 35,5%. Provinsi Sulawesi Barat ada di tingkat kedua sebesar 35%, dan Provinsi Papua ada di tingkat ketiga sebesar 34,6% (Kementerian Kesehatan 2022; Tarmizi 2023).

Sementara itu populasi balita stunting di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5%, yang masih di atas standar WHO, yaitu di bawah 20%. Beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Utara memiliki prevalensi balita stunting yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 26,5% dan Kota Bitung sebesar 22,5% (Kementerian Kesehatan 2022).

Anak yang mengalami stunting pada seribu hari sejak pembuahan hingga usia dua tahun menyebabkan terganggunya tumbuh kembang dan menimbulkan akibat fungsional yang bisa merugikan pada anak. Beberapa konsekuensi tersebut termasuk kognisi dan kinerja pendidikan yang buruk, upah orang dewasa yang rendah, hilangnya produktivitas dan, ketika disertai dengan kenaikan berat badan yang berlebihan di masa anak-anak, meningkatnya risiko

penyakit serius yang berhubungan dengan gizi pada saat dewasa (WHO 2015).

Stunting sering didapati pada anak dengan kurangnya asupan gizi yang sangat lama (kekurangan gizi kronis) dikarenakan memberikan makanan yang tidak cocok dengan kebutuhan gizi (Rahmadhita, 2020). Beberapa kondisi yang menyebabkan stunting, antara lain gizi pada ibu hamil dan balita yang buruk, ibu minim pengetahuan tentang gizi sebelum dan saat hamil dan setelah melahirkan, kurangnya layanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, kurangnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi, dan kurangnya akses keluarga pada air bersih dan sanitasi lingkungan (Sandjojo 2017).

Menurut WHO, stunting tidak dapat disembuhkan namun dapat dicegah (WHO, 2015). Pencegahan stunting perlu dilakukan bagi keluarga dengan anak yang beresiko mengalami stunting. Anak berusia 0 – 23 bulan / anak berusia 24 – 59 bulan yang berasal dari keluarga kurang mampu, pendidikan orang tua yang rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum yang kotor dapat menyebabkan stunting. Hasil pendataan keluarga menunjukkan saat ini jumlah keluarga dengan anak berisiko stunting sebanyak 21,9 juta keluarga (Fatmaningrum et al. 2022).

Adapun cara yang bisa dilakukan oleh peneliti dan tenaga Kesehatan dalam pencegahan stunting adalah melalui pendekatan keluarga dalam memberikan edukasi. Beberapa penelitian sebelumnya mengembangkan berbagai metode dan media untuk memberikan edukasi Kesehatan bagi kader posyandu dan orang tua dalam rangka pencegahan stunting. Penelitian (Astuti, Megawati, and CMS 2018) menemukan bahwa media kartu integrating yang bisa meningkatkan pengetahuan kader posyandu tentang stunting. Penelitian

(Mangundap et al. 2022) menggunakan buka saku sebagai media edukasi kepada kader Kesehatan, dan hasilnya menunjukkan buka saku efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader kesehatan untuk membantu keluarga yang berisiko memiliki anak stunting.

Menurut (Dukhi 2020), diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sesuai dengan konteks, di mana intervensi tidak hanya mempertimbangkan faktor risiko, tetapi juga mempertimbangkan kehadiran tenaga kesehatan dan mengedukasi ibu dan pengasuhan anak mengenai gizi.

Dalam buku ini, penulis bermaksud menyampaikan hasil penelitian tentang edukasi tentang stimulasi pertumbuhan yang diberikan kepada orang tua dengan anak resiko stunting. Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Tenggara, sampel diambil secara klaster acak sejumlah 60 responden terbagi dalam 30 responden kelompok intervensi yaitu yang diberikan edukasi menggunakan video dan 30 responden edukasi menggunakan media leaflet. Selanjutnya di nilai pengetahuan, sikap dan self efikasi (kepercayaan diri) ibu dalam stimulasi pertumbuhan anak dengan stunting.

BAB 2

STIMULASI PERKEMBANGAN PADA ANAK STUNTING

A. Perkembangan Anak

Perkembangan anak adalah perubahan yang terjadi pada seorang anak sejak konsepsi hingga mencapai kedewasaan. Perubahan ini meliputi berbagai aspek, seperti fisik, kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. Perkembangan Fisik: Berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, seperti tinggi badan, berat badan, serta perkembangan organ tubuh. Perkembangan Kognitif: Meliputi perkembangan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Perkembangan Bahasa: Berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Perkembangan Emosional: Meliputi perkembangan perasaan, emosi, dan kemampuan mengelola emosi. Perkembangan Sosial: Berkaitan dengan mampu berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan pengasuh untuk memahami perkembangan anak mereka. Stimulasi yang tepat dapat diberikan dengan memahami tahapan perkembangan anak: Setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan memberikan stimulasi yang sesuai, kita dapat membantu anak mencapai potensi maksimalnya. Pemahaman tentang perkembangan anak dapat menciptakan lingkungan yang tenang,

lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung akan membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Mendeteksi masalah sedini mungkin: Jika ada penyimpangan dalam perkembangan anak, deteksi dini akan memungkinkan penanganan yang lebih efektif.

Pentingnya memantau tumbuh kembang anak dengan deteksi dini. Pemantauan rutin memungkinkan deteksi dini masalah pertumbuhan seperti stunting, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Penting melakukan pemantauan perkembangan anak untuk pengembangan potensi anak yaitu dengan pemantauan yang baik, orang tua dan tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa setiap aspek perkembangan anak berlangsung optimal. Dan intervensi tepat waktu: Memungkinkan pemberian intervensi gizi, medis, atau psikologis yang tepat untuk mencegah dampak jangka panjang stunting.

B. Stunting

World Health Organization (WHO, 2015) menjelaskan stunting sebagai gangguan tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi dan infeksi berulang. Pada tahun 2020, WHO mendefinisikan stunting sebagai anak yang pendek atau sangat pendek karena tinggi badan anak kurang dari standar. Ini disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat diperbaiki.

Antropometri adalah metode yang paling umum untuk mengevaluasi status gizi balita. Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak), antropometri biasanya berkaitan dengan pengukuran berbagai dimensi dan komposisi tubuh dari berbagai usia dan tingkat gizi. Tujuan antropometri adalah untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan dalam asupan protein dan energi.

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Indeks Tb/U

Tabel 1
Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Indeks TB/U

Indeks	Status Gizi	Simpangan Baku (Z-score)
Tinggi badan menurut umur (TB/U) atau	Sangat pendek	<-3 SD
Panjang badan menurut umur (PB/U)	Pendek	-3 SD sampai <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai 3 SD
	Tinggi	>+3 SD

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2020)

Tanda-tanda fisik stunting termasuk pertumbuhan yang lambat atau terhenti, tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dan pertumbuhan yang lebih lambat atau terhenti. Gejala Lain Berat badan kurang, kemampuan motorik yang terhambat, rentan terhadap infeksi.

Metode dan Alat Ukur dalam Identifikasi Stunting. Pengukuran Tinggi Badan yaitu mengukur tinggi atau panjang badan anak dan membandingkannya dengan standar pertumbuhan WHO. Pengukuran Berat Badan yaitu menimbang berat badan anak dan melihat perbandingan dengan tinggi badan untuk menentukan status gizi. Penilaian Lingkar Kepala yaitu mengukur lingkar kepala untuk menilai perkembangan otak dan pertumbuhan tengkorak. Semua pengukuran diploting pada grafik Pertumbuhan untuk mencatat dan memantau perkembangan anak menggunakan grafik pertumbuhan (growth chart) untuk melihat apakah anak mengalami stunting.

Beberapa program yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting yaitu:

1. Perencanaan pernikahan yang baik

Untuk memiliki keturunan bebas dari risiko penyakit atau gangguan, termasuk gangguan pertumbuhan, pernikahan harus mempertimbangkan variasi genetik. Menurut penelitian tentang stunting, faktor genetik calon orang tua harus dipertimbangkan. (Candra, 2020)

2. Suplementasi Ibu hamil

Agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan normal, ibunya memerlukan status kesehatan dan gizi yang baik. Oleh karena itu, ibu hamil harus memenuhi kebutuhan zat gizinya sendiri dan janinnya. Nutrisi tertentu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Mikronutrien dan protein seperti kalsium, iodium, zat besi, dan asam folat termasuk dalam kategori zat gizi ini. (Candra, 2020)

3. ASI Eksklusif

Bayi harus diberikan ASI eksklusif sampai mereka berusia enam bulan. Studi di Jerman menunjukkan bahwa kandungan gizi mikro dan makro ASI dapat mengurangi kemungkinan stunting pada anak. Oleh karena itu, selama enam bulan, ibu harus terus memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kolostrum dan protein susu ibu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang sangat rentan. (Kemenkes, 2019)

4. MPASI sehat

Pilih MPASI yang sehat untuk mendampingi ASI Eksklusif. Ibu dapat mulai memberi bayi makanan pendamping atau MPASI setelah bayi berusia enam bulan. Untuk menghindari stunting, pastikan makanan yang

dipilih memiliki gizi mikro dan makro yang semuanya berasal dari ASI. Selain itu, WHO menyarankan agar nutrisi ditambahkan atau diperkuat ke dalam makanan. Sebaliknya, ibu harus berhati-hati saat memilih produk tambahan. Konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu. (Kemenkes, 2019)

5. Pantau tumbuh kembang anak

Orang tua harus terus mengamati pertumbuhan anak mereka, terutama terkait tinggi dan berat badan mereka. Bawa si Kecil ke posyandu atau klinik khusus anak setiap saat. Akan lebih mudah bagi ibu untuk mengidentifikasi dan merawat gejala awal gangguan. (Kemenkes, 2019)

6. Jaga selalu kebersihan lingkungan.

Seperti yang diketahui, anak-anak sangat mudah sakit, terutama di lingkungan yang kotor. Ini juga meningkatkan kemungkinan secara tak langsung terjadi stunting. paparan terhadap kotoran adalah salah satu faktor yang menyebabkan diare, tetapi penelitian dari Harvard Chan School menemukan bahwa diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan kondisi kesehatan tersebut. (Kemenkes, 2019)

7. Meningkatkan aktivitas luar ruangan anak

Menurut hasil penelitian, kadar vitamin D serum yang rendah terkait dengan stunting dan kekurangan berat badan pada anak-anak. Aktivitas di luar ruangan berarti aktivitas yang dilakukan di luar ruangan di mana anak terpapar sinar matahari secara langsung. Paparan sinar matahari membantu dalam pembentukan vitamin D,

yang membantu anak menghindari kekurangan vitamin D.
(Candra, 2020)

Dampak jangka pendek pada anak dengan stunting yaitu : cenderung lebih rentan terhadap penyakit, mengalami keterlambatan perkembangan motorik, dan memiliki pertumbuhan fisik yang terhambat. Sementara dampak jangka panjang stunting dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, dan penurunan produktivitas di masa dewasa. Selain itu, anak-anak yang stunting memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk diabetes dan hipertensi di kemudian hari.

Implikasi stunting terhadap Kesehatan Fisik yaitu pertumbuhan tinggi badan yang terhambat, berat badan yang kurang, serta perkembangan fisik yang lambat. Kesehatan Kognitif yaitu penurunan kemampuan belajar, prestasi akademis yang rendah, dan gangguan pada perkembangan otak. Sementara kesehatan emosional Anak dengan stunting mungkin mengalami masalah emosional seperti rendah diri, kesulitan bersosialisasi, dan peningkatan risiko gangguan mental.

Uraian ini penulis melaporkan bahwa sasarannya adalah orang tua dalam hal ini ibu yang mempunyai anak yang beresiko stunting juga anak yang sudah menderita stunting.

C. Stimulasi Perkembangan Anak

Bagian ini memberikan panduan mengenai cara-cara untuk merangsang perkembangan anak stunting, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Stimulasi perkembangan adalah serangkaian kegiatan atau intervensi yang dilakukan untuk merangsang

kemampuan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak agar dapat berkembang secara optimal. Pada anak yang mengalami stunting, stimulasi menjadi sangat penting untuk membantu mengatasi hambatan perkembangan yang mungkin mereka alami.

Prinsip-prinsip Stimulasi yang Efektif yaitu pertama konsistensi dan Rutin. Stimulasi harus diberikan secara teratur dan konsisten agar anak merespons dan berkembang dengan baik. Selain itu, stimulasi harus sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak, sehingga kegiatan tersebut relevan dan bermanfaat. Prinsip ketiga adalah lingkungan yang aman dan mendukung, yang berarti anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung untuk merangsang perkembangan mereka secara efektif. Prinsip terakhir adalah hubungan positif, yang berarti hubungan yang positif antara anak dan orang tua atau pengasuh sangat penting dalam proses stimulasi karena memberikan rasa aman dan dorongan bagi anak.

Stimulasi fisik, kognitif, dan sosial emosional adalah tiga jenis stimulasi yang dapat diberikan kepada anak dengan stunting. Stimulasi fisik terdiri dari latihan motorik kasar dan halus. Berlari, melompat, dan memanjat adalah contoh gerakan tubuh yang signifikan dalam latihan motorik kasar. Anak-anak yang stunting harus diajak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi tubuh. Contoh Kegiatan: Bermain bola, melompat tali, atau berjalan di taman. Sementara Motorik Halus yaitu latihan motorik halus melibatkan gerakan yang lebih kecil dan lebih terfokus, seperti menggenggam, menulis, atau menyusun balok. Kegiatan ini membantu memperkuat otot-otot kecil dan meningkatkan koordinasi mata-tangan. Contoh Kegiatan:

menggambar, menyusun puzzle, atau bermain dengan lilin mainan.

Permainan yang mendukung perkembangan fisik seperti permainan berburu harta karun. Permainan ini mengajak anak untuk bergerak dan mencari benda-benda tertentu di sekitar rumah atau taman, yang dapat merangsang motorik kasar dan halus. Permainan bola permainan ini melibatkan berbagai jenis bola untuk melempar, menangkap, atau menendang, yang membantu mengembangkan koordinasi dan kekuatan fisik. Aktivitas menyusun balok anak diminta menyusun balok menjadi bentuk tertentu, yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus dan kreativitas.

Stimulasi kognitif adalah stimulasi kedua yang dapat dilakukan kepada anak untuk mendukung perkembangan anak lebih optimal. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain aktivitas untuk merangsang perkembangan kognitif seperti membaca buku bersama. Membacakan cerita kepada anak membantu mengembangkan kemampuan bahasa, imajinasi, dan pemahaman konsep-konsep baru. Selain itu, permainan edukatif, seperti teka-teki, permainan memori, dan permainan papan, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran kritis seseorang. Juga eksplorasi lingkungan yaitu mengajak anak untuk menjelajahi lingkungan sekitar, mengenal benda-benda baru, dan memahami bagaimana dunia bekerja.

Stimulasi kognitif lainnya dengan metode pembelajaran interaktif. Belajar Sambil Bermain anak-anak belajar lebih baik melalui permainan. Mengintegrasikan elemen pembelajaran ke dalam permainan sehari-hari membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif. Selain itu melalui pertanyaan terbuka yaitu menggunakan

pertanyaan yang mendorong anak untuk berpikir dan merespons dengan penjelasan, seperti "Mengapa kamu berpikir itu terjadi?" atau "Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini?". Stimulasi kognitif lainnya melalui diskusi dan refleksi. Kegiatan ini melibatkan anak dalam diskusi tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Selain stimulasi fisik dan kognitif berikut kita akan bahas stimulasi sosial dan emosional. Interaksi sosial adalah bagian dari pendekatan untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional, misalnya kegiatan mendorong anak untuk bermain dengan teman sebaya dan terlibat dalam aktivitas kelompok membantu mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya, ekspresi emosi adalah mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan mereka secara sehat. Ini bisa melalui percakapan tentang perasaan mereka atau menggunakan gambar dan mainan untuk mewakili emosi. Kemudian bermain peran dengan skenario sederhana membantu anak memahami dan merespons berbagai situasi sosial, serta mengembangkan empati.

Rangkaian stimulasi pada anak, Sebagai orang dewasa yang mengawasi anak harus memiliki strategi komunikasi yang efektif dengan anak yaitu melalui komunikasi dua arah yaitu berbicara dengan anak dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian membangun kepercayaan dan mendorong mereka untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya, gunakan bahasa yang sesuai dengan usia anak, yaitu bahasa yang mudah dipahami, serta menjelaskan konsep-konsep yang mungkin belum mereka mengerti

dengan sederhana. Dan jangan lupa pujian dan dorongan yaitu memberikan pujian dan dorongan positif untuk setiap upaya dan pencapaian mereka, sekecil apapun, membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi anak.

D. Pemantauan Perkembangan Anak

Penulis akan menguraikan bagaimana melakukan pemantauan perkembangan anak sesuai tahap usia, yaitu:

1. Pemantauan Pertumbuhan Fisik

Indikator yang dipantau: Berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala.

Tabel 2.2 Tinggi Badan, Berat Badan, Tinggi Badan Serta Linkar Kepala sesuai usia Anak

Usia	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Lingkar Kepala (cm)
0-3 bulan	3-6 kg	50-60 cm	32-37 cm
3-6 bulan	6-8 kg	60-67 cm	37-42 cm
6-12 bulan	8-10 kg	67-76 cm	42-47 cm
1-2 tahun	10-12 kg	76-86 cm	47-49 cm
2-3 tahun	12-14 kg	86-96 cm	49-51 cm
3-5 tahun	14-18 kg	96-108 cm	51-53 cm

Adapun cara pemantauan yaitu timbang berat badan anak menggunakan timbangan bayi atau balita. Ukur tinggi badan anak dengan pita pengukur atau alat ukur yang sesuai. Ukur lingkaran kepala anak dengan pita meteran, pastikan alat tidak terlalu ketat. Adapun kriteria hasil pemantauan seperti dibawah ini:

- Normal : Berat, dan tinggi badan, serta lingkaran kepala sesuai dengan usia
- Waspada : Berat atau tinggi badan kurang dari rentang normal.
- Stunting : Jika tinggi badan anak di bawah standar yang sesuai untuk usianya.

2. Pemantauan Perkembangan Motorik Kasar

Indikator yang dipantau: Kemampuan bergerak seperti tengkurap, duduk, merangkak, berjalan, dan berlari.

Tabel 2.3: Milestone Motorik Kasar Sesuai Usia

Usia	Milestone Motorik Kasar
0-3 bulan	Tengkurap dengan kepala terangkat
3-6 bulan	Berguling dari perut ke punggung
6-9 bulan	Mulai duduk sendiri
9-12 bulan	Merangkak dan berdiri dengan bantuan
12-18 bulan	Mulai berjalan sendiri
18-24 bulan	Berlari, naik tangga dengan bantuan
2-3 tahun	Melompat, naik tangga sendiri
3-5 tahun	Berlari cepat, melompat dengan kedua kaki

Cara Pemantauan adalah amati apakah anak mampu mencapai milestone sesuai dengan usianya. Jika anak tidak mencapai milestone dalam waktu yang diharapkan, sampaikan kepada orang tua untuk stimulasi lebih lanjut.

3. Pemantauan Perkembangan Motorik Halus

Indikator yang dipantau: Keterampilan menggunakan jari dan tangan, seperti memegang benda, menggenggam, dan menggambar

Tabel 2.4 Milestone Motorik Halus Sesuai Usia

Usia	Milestone Motorik Halus
0-3 bulan	Memegang jari orang tua
3-6 bulan	Meraih dan menggenggam mainan
6-9 bulan	Memindahkan barang dari tangan Satu ke tangan lain
9-12 bulan	Menggunakan jari untuk mengambil benda kecil
12-18 bulan	Mulai menggambar coretan di atas kertas
18-24 bulan	Menyusun balok atau mainan sederhana
2-3 tahun	Menggunakan sendok dan garpu dengan baik
3-5 tahun	Menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran atau garis lurus

Cara Pemantauan berikan objek kecil dan lihat apakah anak dapat meraihnya, memindahkan, atau menggenggamnya. Ajari orang tua untuk memberikan aktivitas yang melibatkan motorik halus seperti menyusun balok atau menggambar.

4. Pemantauan Perkembangan Kognitif

Indikator yang dipantau kemampuan anak untuk memecahkan masalah, belajar, dan berpikir.

Tabel 2.5 Milestone Kognitif Sesuai Usia

Usia	Milestone Kognitif
0-3 bulan	Menatap benda-benda berwarna cerah
3-6 bulan	Merespons suara dengan memalingkan kepala
6-9 bulan	Mengamati gerakan orang di sekitarnya
9-12 bulan	Mencari benda yang tersembunyi (cilukba)

12-18 bulan	Mengenal nama benda sehari-hari
18-24 bulan	Menunjuk gambar atau benda yang dikenal
2-3 tahun	Mengikuti perintah sederhana seperti "ambil bola"
3-5 tahun	Mengenali warna dan angka dasar

Cara Pemantauan Lakukan tes sederhana dengan menunjukkan gambar, benda, atau suara, dan lihat apakah anak merespons sesuai usia. Ajak orang tua untuk melakukan permainan sederhana yang merangsang perkembangan kognitif seperti tebak gambar atau menyusun puzzle sederhana.

5. Pemantauan Perkembangan Sosial dan Emosional

Indikator yang dipantau: Kemampuan anak untuk berhubungan dengan orang lain, mengenali emosi, dan mengekspresikan perasaannya.

Tabel 2.6 Milestone Sosial dan Emosional Sesuai Usia

Usia	Milestone Sosial dan Emosional
0-3 bulan	Tersenyum pada orang yang dikenal
3-6 bulan	Mengenali wajah orang tua dan merespons
6-9 bulan	Mulai merespons ketika dipanggil namanya
9-12 bulan	Memperlihatkan rasa takut pada orang asing
12-18 bulan	Memeluk atau mendekati orang tua saat merasa takut
18-24 bulan	Mulai menunjukkan emosi seperti marah atau senang
2-3 tahun	Bermain berdampingan dengan anak lain (parallel play)

3-5 tahun	Bermain bersama dan mengikuti aturan sederhana
-----------	--

Cara Pemantauan amati bagaimana anak berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, dan orang asing. Berikan saran kepada orang tua untuk melatih interaksi sosial anak melalui permainan kelompok atau kegiatan bersama.

E. Praktik Stimulasi Perkembangan Pada Anak Stunting

Penulis akan menguraikan bagaimana melakukan stimulasi pada anak dengan resiko stunting seperti yang sudah dilakukan oleh penulis dalam penelitian dengan mengedukasi orang tua dengan isi dari edukasi antara lain diuraikan di bawah ini.

Stimulasi motorik kasar aktivitas yang dapat dilakukan yaitu merangkak, berjalan dengan bantuan, bermain bola, dan melompat. Hal ini bertujuan mengembangkan otot-otot besar dan koordinasi tubuh. Cara Melakukan yaitu mendorong anak untuk merangkak dengan menarik mainan di depannya, membantu anak berdiri dan berjalan dengan memegang tangannya. Mengajak anak bermain bola dengan menendang atau melempar bola ke arahnya.

Stimulasi motorik halus aktivitas aktivitas yang dapat dilakukan memegang benda kecil, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam wadah. Tujuannya meningkatkan koordinasi mata-tangan dan ketepatan gerakan. Adapun cara melakukan memberikan benda kecil seperti kancing atau biji-bijian untuk dipegang. Mengajak anak menyusun balok menjadi menara sederhana. Melatih anak untuk memasukkan benda ke dalam wadah yang tepat.

Stimulasi Kognitif berupa permainan edukatif aktifitas yang dapat dilakukan adalah bermain puzzle sederhana,

permainan warna, atau mencocokkan bentuk. Permainan ini bertujuan mengasah kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Adapun cara melakukan yaitu memberikan puzzle dengan potongan besar dan minta anak mencocokkan gambar, mengajak anak mencocokkan warna benda atau bentuk geometris yang berbeda.

Stimulasi Kognitif berupa Interaksi Verbal aktivitas yang dapat dilakukan yaitu membacakan buku cerita, mengajukan pernyataan sederhana dengan tujuan : Meningkatkan kemampuan Bahasa dan berpikir kritis. Adapun cara melakukan yaitu membacakan cerita dengan surat ekspresif dan minta anak untuk menunjukkan gambar yang sesuai. Mengajukan pertanyaan sederhana seperti "Apa warna apel ini?" atau " Di mana burung itu?"

Stimulasi Sosial – Emosional berupa bermain bersama aktivitas yang dapat dilakukan bermain peran, bermain Bersama anak lain. Adapun tujuan stimulasi sosial emosional yaitu meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan empati. Cara melakukan menyanyikan lagu dengan melibatkan gerakan tangan dan ajak anak ikut serta memberikan pelukan, pujian, dan dukungan saat anak berhasil melakukan sesuatu.

Penelitian yang sudah dilakukan stimulasi perkembangan sudah diajarkan kepada orang tua melalui media video untuk kelompok intervensi dan media leaflet untuk kelompok kontrol. Adapun isi video adalah bagaimana orang tua dapat melakukan stimulasi anak dan melakukan pemantauan perkembangan sesuai tahap usia. Hal ini penulis mengambil isi video dan leaflet merujuk dari buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dari Kemenkes, dimana semua orang tua yang memiliki balita memiliki buku tersebut sehingga

memudahkan ibu melakukan stimulasi dan melakukan pemantauan anaknya.

Adapun video dan leaflet sebagai media edukasi berisikan materi perawatan, cara melakukan stimulasi dan juga cek list pemantauan perkembangan anak yang diuraikan sesuai tahap usia perkembangan sebagai berikut:

1. Perawatan Bayi Usia 29 Hari – 3 Bulan

- a. Anda harus selalu mencuci tangan Anda sebelum dan sesudah memegang dan merawat bayi dengan sabun dan air mengalir.
- b. Selama bayi berusia enam bulan, beri air susu ibu karena ASI mengandung semua yang dibutuhkan bayi, seperti faktor pertumbuhan, protein, air, karbohidrat, lemak, mineral, enzim, DHA dan ARA, vitamin, antiparasit, antialergi, antivirus, hormon, dan antibodi. untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik oleh orang tua maupun anggota keluarga.

Stimulasi bayi pada rentang usia 0-3 bulan dengan:

- a. Ciptakan rasa nyaman, aman, dan bahagia
- b. Peluk, ayun, cium
- c. Ajak bicara, tatap mata, senyum,
- d. Meniruhkan ocehan dan wajah bayi
- e. Gantung benda berwarna dan membuat suara
- f. Pegang mainan, meraih, dan angkat kepala.
- g. Interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai
- h. Nyanyian, suara, atau bunyi
- i. Tengkurap-telentang, gulingkan kanan-kiri

Mulailah dengan ceklis di bawah ini untuk memantau tumbuh kembang. Anda dapat memilih untuk

mencentang Ya atau Tidak berdasarkan tumbuh kembang bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan jika dia belum dapat melakukan salah satu ceklis pada usia 3 bulan.

YA TIDAK

1	Secara mandiri bayi dapat mengangkat kepala hingga setinggi 45 derajat?		
2	Bisakah bayi menggerakkan kepalanya dari kiri atau kanan ke tengah?		
3	Apa bayi Anda dapat menatap dan melihat wajah Anda?		
4	Bisakah bayi mengoceh secara spontan?		
5	Sukakah bayi bersuarah keras?		
6	Bisakah bayi terkejut dengan suara keras?		
7	Ketika bayi diajak berbicara, dia membalasnya dengan senyum?		
8	apakah bayi mengenal ibu melalui kontak, penciuman, pendengaran, dan penglihatan?		

Setiap bulan, bawa bayi anda ke Posyandu, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan untuk menerima layanan seperti pemantauan pertumbuhan, imunisasi, dan deteksi perkembangan. Anda juga dapat mengikuti kelas ibu balita bersama ayah atau keluarga.

Manfaat imunisasi:

BCG	Mencegah penyebaran TBC
POLIO	Menghindari polio, yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada lengan dan tungkai anak.
DPT-HB-Hib	Menghindari penyakit difteri yang disebabkan oleh bakteri Hib yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, pertusis atau batuk rejan (batuk 100 hari), tetanus, hepatitis B, dan

	pneumonia, serta meningitis (radang selaput otak).
PCV	Mencegah anak terkena pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus.
RV (Rotavirus)	Mencegah anak dari diare berat yang menyebabkan dehidrasi dan kematian

2. Perawatan Bayi Usia 3 – 6 Bulan

- Anda harus selalu mencuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang dan merawat bayi.
- Untuk mencukupi gizi bayi beri Air Susu Ibu sampai usia 6 bulan karena ASI mengandung semua zat yang dibutuhkan bayi.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik oleh orang tua maupun anggota keluarga.

Stimulasi bayi pada rentang usia 3-6 bulan dengan:

- Peluk, cium, lihat mata, senyum, berbicara,
- Mencari sumber suara
- Melihat wajah di cermin sambil bermain cilukba
- Mengayun, memeluk
- Meraih, Melihat
- Melihat benda bergerak dan benda kecil
- Mengambil benda kecil
- Berguling-guling, duduk

Untuk melacak perkembangan bayi anda, gunakan ceklis di bawah ini dan centang Ya atau Tidak sesuai perkembangan bayi anda. Jika bayi belum bisa melakukan salah satu dari ceklis pada usia enam bulan, bawa bayi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Untuk bayi berusia

tiga hingga lima bulan, gunakan ceklis pemantauan perkembangan yang ada di halaman sebelumnya.

YA TIDAK

1	Bisakah bayi bergerak dari posisi telungkup ke posisi telentang?		
2	Bisakah bayi mengangkat kepalanya sendiri hingga tegak 90 derajat?		
3	Bisakah bayi menjaga kepalanya tetap tegak?		
4	Mainan bertangkai atau mainan kecil dapat dipegang oleh bayi?		
5	Bayi memiliki kemampuan untuk meraih apa pun yang berada dalam jangkauannya?		
6	Bisakah bayi melihat tangannya sendiri?		
7	Bayi berusaha memperluas pandangan?		
8	Bisakah bayi melihat benda-benda kecil?		
9	Bayi membuat suara gembira yang tinggi atau memekik.		
10	Apakah bayi tersenyum ketika mereka melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri?		

Cara membersihkan gigi bayi:

- Pangku anak dengan satu tangan.
- Dengan jari telunjuk ibu, bersihkan gusi anak dengan perlahan dengan kain atau lap basah.

Setiap bulan, bawa bayi anda ke Posyandu, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan:

- Memantau pertumbuhan
- Memantau perkembangan (usia 3 bulan dan 6 bulan)
- Imunisasi sesuai dengan dosis dan usia pemberian
- Ayah, Ibu atau keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita

3. Perawatan Bayi Usia 6 – 9 Bulan

- a. Anda harus mencuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang dan merawat bayi.
- b. Pemberitahuan tentang MP ASI (Air Susu Ibu ditambah Makanan Pendamping) dapat ditemukan pada halaman 90-91.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik oleh orang tua maupun anggota keluarga.

Stimulasi Bayi Pada Rentang Usia 6-9 Bulan Dengan:

- a. Peluk, senyum, berbicara, memanggilnya,
- b. Bersalaman, tepuk tangan, dan melambai
- c. Tunjukkan nama orang (papa atau mama) dan objek di sekitar Anda.
- d. Lihat cermin, Cilukba.
- e. Tunjuk gambar dan sebutkan namanya.
- f. Bacakan cerita
- g. Mengambil mainan dengan kedua tangan.
- h. Tempatkan benda kecil ke dalam botol.
- i. mencari dan menyembunyikan mainan.
- j. Mainan yang terapung di air
- k. Memukul
- l. Merangkan, berdiri berpegangan dan duduk.

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 9 bulan. Jika bayi berusia 6-8 bulan, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya.

YA TIDAK

1	Bayi bisa duduk mandiri?		
2	Berdiri dengan kedua kaki menahan sebagian berat badan bayi?		
3	Bayi dapat merangkak untuk meraih mainan atau mendekati orang lain?		
4	Bisakah bayi memindahkan objek dari tangan satu ke tangan lain?		
5	Bisakah bayi memegang dua benda sekaligus dengan kedua tangannya?		
6	Bisakah bayi mengambil benda sebesar kacang?		
7	Bayi, mamama, bababa, dadada, tatatata?		
8	Mungkinkah bayi mencari mainan atau objek yang dijatuhkan?		
9	Bayi bermain ciluk baa tau bertepuk tangan		
10	Bayi melempar benda karena gembira?		
11	Bayi makan kue sendiri?		

Pertahankan perawatan gigi bayi Anda dan perhatikan pertumbuhan empat gigi seri di rahang atas dan rahang bawah. Bawa bayi Anda setiap bulan ke posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan:

- Memantau tumbuh kembang
- Memantau perkembangan (usia 6 bulan dan 9 bulan)
- Vitamin A (bulan Februari atau Agustus)
- Imunisasi sesuai dengan dosis dan usia pemberian (Lihat halaman 72)
- Seorang ayah, ibu atau keluarga mengikuti kursus ibu balita.

Manfaat Imunisasi

Penyakit campak rubella mencegah penularan penyakit yang dapat menyebabkan radang paru-paru, radang otak, dan kebutaan.

Vitamin A membantu pertumbuhan dan kesehatan mata anak.

4. Perawatan Bayi Usia 9 – 12 Bulan

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir.
- b. Lanjutkanlah dengan memberikan ASI ditambah MP ASI (Makanan Pendamping). Informasi mengenai Makanan Pendamping pada halaman 90-91.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi bayi pada rentang usia 9-12 bulan dengan:

- a. Berbincang dengan boneka
- b. Memperlihatkan benda/orang/organ tubuh yang sudah dikenalkan,
- c. Menyebutkan benda/orang/organ tubuh yang sudah dikenalkan
- d. Membacakan dongeng pada saat menyuruh menunjuk dan mengenalkan
- e. Ajak untuk memegang mainan dengan dua tangan
- f. Mengisi wadah dengan benda kecil
- g. Balok yang disusun sendiri
- h. Mencari mainan yang disembunyikan
- i. Mencoret-coret kertas dengan pensil
- j. Berdiri berpegangan, merangkak, duduk
- k. Jinjit dan jalan mundur

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 1 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 9-11 bulan.

YA TIDAK

1	Bayi senang diajak bermain "CILUKBA"?		
2	Bayi belajar berdiri dengan berpegangan di kursi atau berdiri selama 30 detik?		
3	Bayi takut pada orang yang belum dikenal, mengenal anggota keluarga?		
4	Bayi mengulurkan lengan atau badan untuk mengambil mainan yang di sukai?		
5	Bayi bereaksi terhadap suara bisikan atau suara yang perlahan?		
6	Bayi menyebut dua sampai tiga suku kata yang sama tanpa arti?		
7	Bayi dapat berjalan dengan dituntun?		
8	Bayi mampu berdiri dengan menompang badannya sendiri?		
9	Bayi menirukan atau mengulang bunyi yang didengar?		
10	Bayi memasukkan benda ke mulut?		
11	Bayi mengeksplorasi sekitar, ingin menyentuh apa saja, ingin tahu?		
12	Bayi bisa menggenggam erat pensil?		

Lanjutkan perawatan gigi bayi anda

Tetap pantau pertumbuhan gigi anak pada usia 9 bulan apakah ada gigi geraham 4 buah, gigi seri 8 buah, bersihkan gigi anak dengan kasa yang diberi air hangat dengan sedikit pasta gigi.

Setiap bulan bawalah anak di Fasilitas Kesehatan/Posyandu/Puskesmas/ terdekat agar mendapatkan pemeriksaan pertumbuhan;

- a. Kelas Ibu Balita diikuti Ibu/ ayah/ keluarga
- b. Pemantauan pertumbuhan
- c. Memantau perkembangan usia 9 bulan dan 1 tahun
- d. Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus),
- e. Imunisasi sesuai dengan dosis dan usia pemberian

5. Perawatan Anak Usia 12 – 18 Bulan

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir
- b. Lanjutkanlah dengan memberikan ASI ditambah MP ASI (Makanan Pendamping). Informasi mengenai Makanan Pendamping pada halaman 90-91.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 12-18 bulan dengan:

- a. Melempar dan menangkap bola
- b. Memasang puzzle, menyusun balok, menggambar
- c. Menendang bola, bermain air, meniup
- d. Menceritakan mengenai gambar-gambar yang ada di buku
- e. Bernyanyi, menyebutkan nama benda

- f. Naik turun tangga, berjalan mundur
- g. Mengatakan keinginan, main telpon-telponan
- h. Bermain petak umpet dengan teman sebaya
- i. Makan bersama
- j. Membuka baju, merapikan mainan
- k. Merangkai manik-manik besar

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 18 bulan. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 1 tahun – 1 tahun 5 bulan.

		YA	TIDAK
1	Anak mampu berdiri tanpa berpegangan secara mandiri?		
2	Anak mampu membungkuk mengambil mainan dan dapat berdiri kembali?		
3	Anak mampu berjalan mundur 5 langkah?		
4	Anak mampu memanggil papa dengan kalimat "ayah", memanggil mama dengan kalimat "ibu"?		
5	Anak mampu menyusun dua kubus?		
6	Anak mampu memasukkan kubus di kotak?		
7	Anak mampu memperlihatkan apa yang diinginkan tanpa merengek/menangis, anak mampu menarik tangan ibu atau mengeluarkan suara yang menyenangkan?		
8	Anak mampu menunjukkan rasa bersaing/cemburu?		

Lanjutkan perawatan gigi anak anda.

Tetap pantau pertumbuhan gigi anak setiap usia 1 tahun 6 bulan apakah ada gigi susu yang berjumlah sebanyak 16 buah.

Setiap bulan bawalah anak anda ke Fasilitas Kesehatan/Posyandu/Puskesmas/ terdekat agar mendapatkan pemeriksaan pertumbuhan;

- a. Imunisasi sesuai dengan dosis dan usia pemberian
- b. Pemantauan perkembangan usia 18 bulan, 15 bulan dan 12 bulan;
- c. Kapsul vitamin A (Februari dan Agustus); Obat cacingan
- d. Pemantauan pertumbuhan
- e. Kelas Ibu Balita diikuti Ibu/ ayah/ keluarga

Manfaat Imunisasi Lanjutan.

Imunisasi lanjutan merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk memperpanjang masa perlindungan anak dan untuk mempertahankan tingkat kekebalan.

Manfaat Obat Cacing.

Memberikan obat cacing sangat bermanfaat, sehingga dengan cara tersebut bisa mencegah dan sebagai salah satu pengobatan infeksi cacingan agar dampak yang ditimbulkan akibat cacingan dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu, selalu menjaga anak anda supaya terhindar dari infeksi cacingan yaitu dengan cara menerapkan PHBS.

6. Perawatan Anak Usia 18 – 24 Bulan

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir

- b. Lanjutkanlah dengan memberikan ASI ditambah MP ASI (Makanan Pendamping). Informasi mengenai Makanan Pendamping di halaman 90-91.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 18-24 bulan dengan:

- a. Bernyanyi, berbincang-bincang, saling bertukar pertanyaan, menceritakan pengalaman
- b. Bermain telpon-telponan, diskusi (tanya jawab)
- c. Membantu pekerjaan, perintah sederhana
- d. Merapikan mainan, melepas baju
- e. Makan bersama menggunakan sendok dan garpu
- f. Membentuk lilin, menggambar mengatur puzzle atau balok
- g. Bermain petak umpet, membuat rumah-rumahan,
- h. Melompat, berjalan, berlari
- i. Naik turun tangga, berdiri 1 kaki
- j. Menendang bola, melempar, menangkap,

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 2 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 18-23 bulan.

YA TIDAK

1	Anak mampu memungut benda-benda dengan ukuran kecil dengan jari telunjuk dan ibu jari?		
---	--	--	--

2	Anak mampu melempar bola ke arah sasaran saat bermain?		
3	Anak mampu belajar minum atau makan sendiri, memegang cangkir sendiri?		
4	Anak mampu menyebutkan tiga sampai enam kalimat yang memiliki makna?		
5	Anak mampu berjalan tanpa tergoyang-goyang ke kiri kanan?		
6	Anak mampu membangun 4 buah kubus sesuai instruksi?		
7	Anak mampu berdiri spontan tanpa berpegangan selama 30 detik?		
8	Anak mampu meniru/membantu pekerjaan di rumah?		

Mulailah perawatan gigi secara rutin pada anak anda. Menggosok gigi anak setelah sarapan dan sebelum tidur gunakan pepsodent mengandung fluor cukup 1/2 biji kacang polong (selapis tipis) dengan sikat gigi khusus anak yang berbulu lembut, kemudian pantau secara rutin pertumbuhan gigi pada usia 2 tahun apakah ada gigi susu berjumlah 20 buah?

Setiap bulan bawalah ke Fasilitas kesehatan atau Posyandu atau Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pelayanan pada anak anda

- Imunisasi sesuai dengan dosis dan usia pemberian
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita
- Memantau perkembangan usia 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 8 bulan dan 2 tahun
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari dan Agustus)
- Pemantauan pertumbuhan

7. Perawatan Anak Usia 2 – 3 Tahun

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir
- b. Makanan keluarga dengan bervariasi dapat memenuhi gizi anak yaitu buah, sayur, lauk pauk minyak dan makanan pokok

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 2-3 tahun dengan:

- a. Menyebutkan guna dari setiap benda, beserta sifatnya, nama benda
- b. Membacakan cerita sekaligus diskusi tanya jawab
- c. Mengelompokkan benda sejenis
- d. Minta anak menceritakan pengalaman
- e. Menyanyi, nonton TV ditemani maksimal 1 jam
- f. Mencuci tangan setiap selesai cebok, rapikan mainan, menggunakan pakaian
- g. Setiap makan menggunakan sendok dan garpu
- h. Mencocokkan benda dan gambar
- i. Menangkap, melempar
- j. Berlari, memanjat, merayap, melompat
- k. Memasang puzzle, menyusun balok, menggambar, menempel
- l. Menghitung

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa

menggunakan salah satu ceklis pada usia 3 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 24-35 bulan.

YA TIDAK

1	Anak mampu menyebutkan dengan benar nama dua benda atau lebih setelah melihat gambar?		
2	Anak bisa membantu membantu mengangkat piring atau memungut mainannya sendiri jika diminta?		
3	Anak bisa melepas pakaiannya sendiri?		
4	Anak bisa naik tangga dan berjalan tanpa dibantu?		
5	Anak mampu makan nasi tanpa banyak tumpah secara mandiri?		
6	Anak mampu main bola kecil kemudian ditendang?		
7	Anak mampu mencoret kertas menggunakan pensil?		
8	Anak mampu ketika diminta menyebutkan 1 atau lebih bagian tubuhnya?		
9	Anak mampu berbicara dengan baik, menggunakan 2 kata?		

Setelah makan dan sebelum tidur beri perawatan gigi pada anak anda sehingga anak akan terbiasa dan mudah mengingat bahwa wajib untuk menggosok gigi.

Setiap bulan bawalah ke Fasilitas kesehatan atau Posyandu atau Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pelayanan pada anak anda

a. Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita

- b. memantau perkembangan usia 2 tahun, 2 tahun 6 bulan dan 3 tahun.
- c. Pemantauan pertumbuhan
- d. Kapsul Vitamin A (bulan Februari dan Agustus) obat cacing

8. Perawatan Anak Usia 3 – 4 Tahun

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir
- b. Makanan keluarga dengan bervariasi dapat memenuhi gizi anak yaitu buah, sayur, lauk pauk minyak dan makanan pokok

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 3-4 tahun dengan:

- a. Menyebutkan guna benda-benda, sifatnya, nama benda
- b. Bacakanlah cerita sekaligus diskusi tanya jawab
- c. Mengelompokkan benda sejenis
- d. Minta anak menceritakan pengalaman
- e. Menyanyi, nonton TV ditemani
- f. Mencuci tangan setiap selesai cebok, rapikan mainan, menggunakan pakaian
- g. Makan menggunakan sendok garpu
- h. Mencocokkan benda dan gambar
- i. Menangkap, melempar
- j. Berlari, memanjat, merayap, melompat
- k. Menyusun balok atau puzzle, menggambar, menempel
- l. Menghitung

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 4 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 36-47 bulan.

YA TIDAK

1	Anak mampu berdiri selama dua detik dengan 1 kaki?		
2	Anak mampu memahami arti kalimat di depan, atas, dibawah?		
3	Anak mampu mengenakan sepatu sendiri?		
4	Anak mampu lompat dengan kedua kaki diangkat?		
5	Anak mampu menyebut nama, umur, tempat?		
6	Anak mampu mengenali 2 sampai 4 warna?		
7	Anak mampu melukis garis lurus?		
8	Anak mampu membangun 8 buah kubus sesuai instruksi?		
9	Anak mampu mencuci tangan dan mengeringkan sendiri?		
10	Anak mampu mendengarkan cerita?		
11	Anak mampu mengayuh sepeda roda tiga?		
12	Anak mengikuti aturan setiap permainan yang diperankan bersama teman?		
13	Anak mampu memakai kemeja, baju, celana panjang?		

Setelah makan dan sebelum tidur beri perawatan gigi pada anak anda sehingga anak akan terbiasa dan mudah mengingat bahwa wajib untuk menggosok gigi.

Setiap bulan bawalah ke Fasilitas kesehatan atau Posyandu atau Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pelayanan pada anak anda

- a. Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita
- b. Memantau perkembangan usia 3 tahun, 3 tahun 6 bulan dan 4 tahun.
- c. Pemantauan pertumbuhan
- d. Kapsul Vitamin A (bulan Februari dan Agustus)

9. Perawatan Anak Usia 4 – 5 Tahun

- a. Sebelum dan sesudah bermain dan merawat anak, sebaiknya selalu cuci tangan anda menggunakan sabun di air kran yang mengalir
- b. Makanan keluarga dengan bervariasi dapat memenuhi gizi anak yaitu buah, sayur, lauk pauk minyak dan makanan pokok

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 4-5 tahun dengan:

- a. Minta anak untuk menceritakan pengalamannya dan ajak bermain peran
- b. Memperkuat kepercayaan diri anak
- c. Menyebut angka berurutan
- d. Melukis orang, menghafal huruf
- e. Bermain bola dan lompat tali
- f. Melatih mengikuti aturan dalam setiap permainan

- g. Mengajak anak menggosok gigi bersamaan dan latih menggosok gigi secara mandiri
- h. Latih menggunakan pakaian secara mandiri
- i. Mengenalkan nama-nama hari

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 5 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 48-59 bulan.

YA TIDAK

1	Anak mampu berdiri 6 detik dengan 1 kaki		
2	Anak mampu menyebutkan nama-nama hari dengan mudah		
3	Anak mampu menyikat gigi secara mandiri		
4	Anak mengekspresikan perasaannya dengan tidak rewel dan tenang ketika tidak bersama ibu		
5	Anak mampu melukiskan lingkaran		
6	Anak mampu menghitung jari, menyebut angka		
7	Anak mampu menggunakan pakaian secara mandiri tanpa dibantu		
8	Anak mampu bicara yang dipahami dengan mudah		
9	Anak mampu membandingkan/ membedakan ukuran benda		
10	Anak mampu menari		
11	Anak bisa menyebut nama lengkap tanpa dibantu		
12	Anak mampu melompat dengan 1 kaki		

13	Anak mampu menuliskan tanda silang		
14	Anak mampu melukis tiga bagian tubuh manusia		
15	Anak mampu mengancing pakaian boneka/baju		
16	Anak mampu memperlihatkan kata-kata baru yang sudah dipelajari		
17	Anak suka bertanya mengenai sesuatu		
18	Anak mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan kalimat yang benar		

Setelah makan dan sebelum tidur beri perawatan gigi pada anak anda sehingga anak akan terbiasa dan mudah mengingat bahwa wajib untuk menggosok gigi.

Setiap bulan bawalah ke Fasilitas kesehatan atau Posyandu atau Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan pelayanan pada anak anda.

- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita
- Memantau perkembangan anak usia 4 tahun, 5 tahun 6 bulan dan 5 tahun 8 bulan.
- Pemantauan pertumbuhan
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari dan Agustus), obat cacing

10. Perawatan Anak Usia 5 – 6 Tahun

- Sebelum Dan Sesudah Merawat Anak, Sebaiknya Selalu Cuci Tangan Anda Menggunakan Sabun Di Air Mengalir.
- Makanan Keluarga Yang Bervariasi Mampu Memenuhi Gizi Anak Yaitu Makanan Buah, Sayur, Lauk Pauk, Minyak Dan Makanan Pokok.

Ketika bayi dalam suasana menyenangkan terapkan stimulasi sesuai dengan usia bayi, baik itu bersama anggota keluarga maupun orang tua.

Stimulasi anak pada rentang usia 5-6 tahun dengan

- a. Menulis nama, menggambar, mewarnai, menyusun balok, memasang puzzle
- b. Bacakan buku, bercerita, tanya jawab
- c. Mengerti nama, fungsi benda-benda
- d. Masak-masakan, makan dengan sendok garpu
- e. Berlari, melompat, melempar, menangkap
- f. Menyanyi, nonton TV ditemani maksimal 1 jam
- g. Mencuci tangan setiap selesai cebok, rapikan mainan, menggunakan pakaian
- h. Menjahit, menempel, menggunting
- i. Urutan, mengerti aturan, menghafal, mengingat
- j. Membandingkan banyak sedikit, besar kecil
- k. Mengenal simbol, huruf, angka, jam, hari, tanggal
- l. Merayap, ayunan, memanjat, Sepeda roda 3
- m. Menghitung, konsep setengah dan satu
- n. Berjualan, mengukur, bertukang

Untuk memantau perkembangan, ceklis di bawah ini. Anda dapat memilih untuk mencentang Ya atau Tidak berdasarkan perkembangan bayi Anda. Bayi harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit jika dia belum bisa menggunakan salah satu ceklis pada usia 6 tahun. Kemudian, gunakan ceklis pemantauan perkembangan halaman sebelumnya untuk anak usia 60-71 bulan.

YA TIDAK

1	Anak mampu berpakaian sendiri tanpa dibantu?		
---	--	--	--

2	Anak mampu berdiri menggunakan 1 kaki selama 11 detik?		
3	Anak mampu mengambil bola kecil dengan kedua tangannya?		
4	Anak mampu berjalan lurus?		
5	Anak mampu mengikuti aturan permainan?		
6	Anak mampu memahami arti lawan kata yang dijabarkan?		
7	Anak mampu mengungkapkan simpati terhadap sesuatu?		
8	Anak mampu mengenal warna-warni?		
9	Anak mampu mengenal dan menghitung angka 5 -10?		
10	Anak mampu mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata		
11	Anak mampu melukis segi empat?		
12	Anak mampu menjawab pertanyaan mengenai setiap benda terbuat dari apa?		
13	Anak mampu melukis 6 bagian atau melukis orang?		

Selalu libatkan anak dalam perawatan gigi dengan mengingatkan anak menyikat gigi

- Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin untuk anak usia 3-6 bulan pada dokter gigi/perawat gigi di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya
- Gigi susu akan tumbuh semua: 20 buah, mulai tumbuh 2 gigi geraham tetap, rahang bawah pertama kanan dan kiri

Ketika anda perlu berkonsultasi tentang mengenai kesehatan anak Anda, bawalah ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan terdekat.

F. Praktik Teknik Pengasuhan Pada Anak Stunting

Bagian ini penulis memberikan panduan tentang teknik pengasuhan yang efektif untuk anak stunting serta dukungan psikososial yang diperlukan oleh keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Ada dua Teknik Pengasuhan yaitu pengasuhan positif dan dukungan psikososial untuk keluarga.

Teknik Pengasuhan Positif pada prinsipnya adalah pengasuhan yang mendukung perkembangan anak yaitu Konsistensi dalam Pengasuhan. Konsistensi dalam pengasuhan menyediakan rutinitas yang teratur dan aturan yang konsisten membantu anak merasa aman dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Konsistensi ini juga penting dalam mendorong perkembangan yang sehat. Selanjutnya Pendekatan berbasis kasih sayang orang tua atau dewasa lain yang bertanggung jawab pada anak haruslah menunjukkan cinta dan dukungan secara aktif, seperti memberikan pujian, pelukan, dan perhatian, membantu anak merasa dicintai dan dihargai. Ini penting untuk perkembangan emosional yang sehat. Kemudian pemberdayaan dan pemberian pilihan yaitu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sederhana membantu mereka merasa dihargai dan membangun kemandirian. Misalnya, memberikan pilihan dalam kegiatan sehari-hari dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pengasuhan selanjutnya adalah disiplin yang positif yaitu menggunakan pendekatan disiplin yang mendidik, bukan menghukum,

membantu anak belajar dari kesalahan mereka. Teknik seperti time-out, diskusi tentang perilaku, dan konsekuensi alami lebih efektif daripada hukuman fisik atau verbal.

Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak Stunting Orang tua adalah model utama bagi anak. Memberikan teladan dalam pola makan yang sehat, kebiasaan hidup sehat, dan perilaku positif sangat penting. Keterlibatan orang tua dalam setiap aspek kehidupan anak membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Keterlibatan Anggota Keluarga Lain. Anggota keluarga lain, seperti kakek-nenek, paman, atau bibi, juga memainkan peran penting dalam mendukung pengasuhan. Mereka dapat membantu dengan menyediakan dukungan emosional, berbagi pengalaman, dan membantu dalam perawatan sehari-hari. Komunikasi Keluarga yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dalam keluarga membantu memastikan bahwa semua anggota keluarga bekerja sama dalam mendukung anak. Ini juga penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengasuhan.

Dukungan Psikososial untuk Keluarga penting dalam mengatasi stres dan kecemasan pada orang tua. Orang tua seharusnya dapat mengakui dan mengelola stres. Orang tua dari anak stunting sering menghadapi tekanan yang besar. Penting untuk mengakui stres yang mereka alami dan mencari cara-cara untuk mengelolanya, seperti melalui teknik relaksasi, olahraga, atau berbicara dengan orang lain. Mencari Dukungan Sosial dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok pendukung sangat penting dalam membantu orang tua mengatasi stres. Bergabung dengan komunitas

atau kelompok orang tua yang mengalami situasi serupa dapat memberikan dukungan emosional dan saran praktis. Selanjutnya adalah manajemen waktu mengatur waktu dengan baik antara tanggung jawab pengasuhan dan kebutuhan pribadi sangat penting untuk mencegah burnout. Membuat jadwal dan prioritas dapat membantu orang tua mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih efisien.

Pendampingan Psikologis bagi Keluarga dapat berupa konseling individu dan keluarga. Konseling dengan psikolog atau konselor dapat membantu keluarga mengatasi tantangan emosional yang terkait dengan merawat anak stunting. Ini bisa mencakup konseling individu untuk orang tua atau sesi konseling keluarga untuk memperkuat komunikasi dan dukungan di antara anggota keluarga. Selanjutnya adalah edukasi tentang Kesehatan Mental hal ini memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya kesehatan mental dan cara menjaga keseimbangan emosional membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan. Ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana stres dapat memengaruhi anak dan cara mengatasi dampaknya.

Program dukungan psikososial Terlibat dalam program-program dukungan psikososial yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat memberikan akses ke sumber daya yang bermanfaat, seperti terapi, pelatihan keterampilan, dan kelompok pendukung.

BAB 3

EDUKASI KESEHATAN

A. Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Ibu dengan Anak Stunting

Pendidikan kesehatan bagi para ibu merupakan strategi penting dalam memerangi stunting. Stunting, akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Pendidikan ini memberdayakan para ibu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perawatan dan gizi yang lebih baik bagi anak-anak mereka, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil kesehatan dan penurunan angka stunting. Berikut adalah poin-poin penting yang menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan bagi ibu dengan anak stunting:

1. Meningkatkan pengetahuan ibu

Mendidik ibu tentang gizi yang tepat dan perawatan yang baik secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan praktik mereka. Studi menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih siap untuk menyediakan pola makan seimbang dan perawatan yang tepat, yang penting untuk mencegah dan mengelola stunting (Haryanti et al., 2024; Mazida et al., 2024; Vikram & Vanneman, 2020). Program pendidikan daring telah efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan untuk balita yang mengalami stunting,

meskipun program tersebut mungkin tidak mengubah sikap secara signifikan (Faridah et al., 2024a).

2. Dampak pada hasil kesehatan anak

Pendidikan ibu secara positif memengaruhi status gizi anak. Ibu yang berpendidikan lebih cenderung memastikan anak-anak mereka menerima nutrisi yang cukup, sehingga mengurangi risiko terhambatnya pertumbuhan (Javid & Pu, 2020; Sarwar et al., 2024; Vikram & Vanneman, 2020) [5]. Ibu dengan literasi kesehatan yang lebih tinggi lebih cenderung memanfaatkan layanan pemantauan dan promosi pertumbuhan (GMP), yang sangat penting untuk deteksi dini dan intervensi dalam terhambatnya pertumbuhan (Edae et al., 2024).

3. Perubahan perilaku dan pemberdayaan

Intervensi edukasional dapat meningkatkan efikasi diri ibu dan praktik yang terkait dengan nutrisi dan kesehatan anak. Misalnya, ibu yang menerima pendidikan nutrisi menunjukkan peningkatan efikasi diri dalam menyediakan makanan yang meningkatkan pertumbuhan (Mahmudiono et al., 2018). Metode edukasional yang interaktif dan berkelanjutan, seperti metode Ceramah, Curah Pendapat, Demonstrasi (CBD), telah terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu terhadap pencegahan terhambatnya pertumbuhan (Permatasari et al., 2021; Yunitasari et al., 2020).

4. Mengatasi faktor sosial ekonomi

Pendidikan juga membantu para ibu menghadapi tantangan sosial ekonomi. Misalnya, para ibu dengan pendidikan dan sistem dukungan yang lebih baik

cenderung lebih mampu mengatasi hambatan terkait pendapatan dan akses ke layanan kesehatan, yang sangat penting dalam mengelola stunting (Darwis et al., 2021a; Ikasari et al., 2024; Tafesse et al., 2021).

5. Manfaat Jangka Panjang

Pendidikan ibu dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan kesehatan. Di wilayah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, peningkatan kesempatan pendidikan bagi para ibu dapat menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak (Ohonba et al., 2019). Mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam program komunitas dan layanan kesehatan memastikan bahwa intervensi bersifat spesifik konteks dan berkelanjutan, yang mengarah pada peningkatan kesehatan anak dalam jangka panjang (Ain et al., 2024).

B. Peran Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Edukasi

Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam memberikan edukasi kepada ibu tentang stunting dan pencegahannya. Keterlibatan mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan edukasi langsung hingga memberdayakan ibu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Beberapa peran dan tanggung jawab utama tenaga kesehatan dalam pemberian edukasi kepada ibu, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan

Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada ibu tentang penyebab, pencegahan, dan penanganan stunting. Ini termasuk memberikan informasi tentang nutrisi, kebersihan, dan

praktik perawatan kesehatan yang tepat (Bagasraga et al., 2023; Darwis et al., 2021a; Rania et al., 2024). Metode edukasi kesehatan yang interaktif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kemampuan orang tua dalam merawat anak yang mengalami stunting (Darwis et al., 2021a).

2. Panduan Gizi

Memberdayakan ibu melalui model pembelajaran yang diatur sendiri dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan nutrisi yang tepat kepada anak usia 6-24 bulan. Ini termasuk menyusui, menyiapkan makanan, dan pemberian makanan yang responsif (Hastuti et al., 2024). Tenaga kesehatan dapat membimbing ibu tentang pemberian makanan pendamping yang seimbang, yang sangat penting untuk mencegah dan menangani stunting (Hastuti et al., 2024; Suminar et al., 2021).

3. Dukungan dan Konseling

Dukungan dan konseling berkelanjutan dari petugas kesehatan membantu para ibu mengadopsi dan mempertahankan praktik-praktik yang sehat. Ini termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala (Altobelli et al., 2020; Paintal & Aguayo, 2016). Petugas kesehatan juga dapat mengatasi kepercayaan dan praktik tradisional yang dapat menghambat gizi dan perawatan anak yang tepat (Paintal & Aguayo, 2016).

4. Keterlibatan Masyarakat

Petugas kesehatan sering kali bekerja sama dengan petugas kesehatan masyarakat (CHW) untuk menjangkau

khalayak yang lebih luas. Melatih CHW untuk berbagi pengalaman dan memberikan perawatan yang kompeten secara budaya dapat meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan (Altobelli et al., 2020). Program dan intervensi berbasis masyarakat, seperti yang dilaksanakan di Ghana dan Bangladesh, telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan pendidikan gizi (Bigool, 2024; de Hoop et al., 2020).

5. Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Mendorong para ibu untuk memanfaatkan layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan dan imunisasi rutin, sangat penting. Petugas kesehatan dapat meningkatkan kunjungan ibu ke pusat-pusat layanan kesehatan dengan memberikan konseling dan membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses (Has et al., 2024; Rania et al., 2024).

C. Pendekatan Holistik dalam Edukasi dan Stimulasi Anak Stunting

Pendekatan holistik dalam menangani stunting pada anak melibatkan integrasi berbagai aspek kesehatan, gizi, pendidikan, dan dukungan sosial untuk memastikan perkembangan yang komprehensif. Berikut adalah komponen dan strategi utama dalam melakukan pendekatan secara holistik:

1. Kesehatan dan gizi

Memastikan gizi dan perawatan kesehatan yang memadai sejak usia dini sangatlah penting. Intervensi seperti peningkatan pemberian makanan bayi dan anak

kecil (IYCF) dan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan (Bhutta et al., 2013; Piper et al., 2023). Menangani kekurangan gizi ibu dan menyediakan perawatan antenatal dapat secara signifikan mengurangi risiko stunting pada anak (Bhutta et al., 2013; Elisaria et al., 2021).

2. Stimulasi dan pendidikan dini

Memberikan stimulasi perkembangan dini melalui program pendidikan dapat meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Pendidikan daring bagi para ibu telah terbukti meningkatkan pengetahuan mereka tentang stimulasi perkembangan, meskipun mungkin tidak mengubah sikap secara signifikan (Faridah et al., 2024a).

Menggabungkan pendidikan anak usia dini dengan pendidikan gizi dapat meningkatkan asupan makanan dan hasil perkembangan pada anak-anak (Huriah et al., 2021). Program yang mencakup domain fisik, kognitif, dan afektif, seperti intervensi literasi fisik, juga bermanfaat (Grauduszus et al., 2024).

3. Dukungan Komunitas dan Keluarga

Melibatkan keluarga dan komunitas dalam pendidikan dan perawatan anak-anak yang mengalami stunting sangatlah penting. Pendekatan holistik yang melibatkan petugas kesehatan komunitas dan lembaga lokal dapat memastikan keberlanjutan dan keandalan program (Homsy & Hussein, 2013; Martinez et al., 2019). Mendidik dan memberdayakan orang tua, terutama ibu, tentang gizi, praktik kesehatan, dan stimulasi

perkembangan sangatlah penting. Pelatihan dan sumber daya yang mendukung dapat membantu orang tua memberikan perawatan dan stimulasi yang lebih baik bagi anak-anak mereka (Agha et al., 2007; Faridah et al., 2024a; Giyaningtyas et al., 2019).

4. Kebijakan dan Koordinasi

Koordinasi kebijakan lintas sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial sangat penting untuk implementasi program holistik yang efektif. Badan nasional dapat memastikan bahwa program mempertahankan pendekatan terpadu dan memfasilitasi transisi yang lancar bagi anak-anak (Del Carmen Casanovas et al., 2013; Homsy & Hussein, 2013).

Adapun strategi dalam implementasinya, yaitu:

1. Intervensi Multi-Sektoral

Menerapkan intervensi terpadu yang menangani berbagai faktor risiko secara bersamaan, seperti kesehatan, gizi, dan pendidikan dini, dapat memberikan efek sinergis dalam mengurangi stunting dan mendorong perkembangan holistik (Elisaria et al., 2021; Hartinger et al., 2020).

2. Program Jangka Panjang

Program yang berkelanjutan dan jangka panjang diperlukan untuk menyaksikan pengurangan signifikan dalam stunting dan peningkatan hasil perkembangan. Intervensi jangka pendek mungkin tidak menunjukkan hasil signifikan langsung tetapi dapat menghasilkan manfaat jangka panjang (Elisaria et al., 2021).

3. Pemanfaatan Teknologi

Memanfaatkan teknologi, seperti platform pendidikan daring dan alat bantu pengambilan keputusan berbasis data, dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas intervensi pendidikan dan kesehatan (Faridah et al., 2024a; Lee & Liu, 2021; Rachmawati et al., 2022).

Dengan mengintegrasikan komponen dan strategi ini, pendekatan holistik dapat secara efektif mengatasi masalah multifaset dari stunting dan meningkatkan perkembangan menyeluruh dari anak-anak yang terkena dampak.

D. Metode Edukasi: Konseling, Penyuluhan, dan Media Digital

Untuk mengatasi masalah stunting pada anak, berbagai metode edukasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik para ibu. Metode-metode ini meliputi konseling, program penjangkauan, dan media digital.

Berikut adalah ringkasan efektivitas metode-metode ini berdasarkan penelitian terkini:

1. Konseling

Sesi konseling, baik berbasis individu maupun kelompok, telah terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan para ibu tentang stunting dan praktik gizi yang tepat. Misalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa konseling kepada para ibu menggunakan metode demonstrasi dan pemutaran video secara signifikan meningkatkan pengetahuan mereka tentang stunting (Siokal et al., 2025). Penelitian lain menyoroti pentingnya edukasi kesehatan yang berkelanjutan dan interaktif

untuk meningkatkan pemahaman dan praktik terkait dengan stunting (Darwis et al., 2021b). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kami bahwa metode edukasi melalui video efektif dalam meningkatkan self efikasi ibu dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang balita dengan stunting.

2. Program Penjangkauan

Program berbasis masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan program Bina Keluarga Balita telah efektif dalam mendidik para ibu tentang pencegahan stunting. Program-program ini sering kali melibatkan interaksi langsung dengan petugas kesehatan dan pemimpin masyarakat, yang membantu dalam menyebarkan informasi penting (Dolifah et al., 2021; Kusumasari & Subhiyakto, 2024). Selain itu, penggunaan kerangka pendidikan terstruktur seperti model I-CARE telah terbukti meningkatkan pemahaman dan praktik ibu mengenai pencegahan stunting (Dolifah et al., 2021).

3. Media Digital

Pendidikan Daring dan Aplikasi Seluler: Platform digital, termasuk aplikasi seluler dan intervensi pendidikan daring, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan ibu. Misalnya, penggunaan grup WhatsApp untuk menyampaikan konten pendidikan secara signifikan meningkatkan pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan untuk balita yang mengalami stunting (Faridah et al., 2024b). Demikian pula, aplikasi seluler seperti Saathealth menyediakan konten interaktif dan menarik yang membantu orang tua memahami dan

menerapkan praktik gizi yang lebih baik (Ganju et al., 2021).

Platform Berbasis Web: Mengembangkan layanan pendidikan berbasis web, seperti yang menggunakan kerangka ReactJs, dapat mengoptimalkan penyampaian informasi pencegahan stunting. Platform ini dapat menawarkan fitur-fitur seperti layanan pemeriksaan gizi, konsultasi dengan ahli gizi, dan akses ke artikel pendidikan (Kusumasari & Subhiyakto, 2024).

BAB 4

PENGETAHUAN, SIKAP DAN SELF AFIKASI

A. Pengetahuan.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar yaitu tingginya prevalensi stunting yang merupakan masalah gizi kronis pada balita yang juga termasuk negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). menunjukkan bahwa prevalensi balita pendek (stunting) berfluktuasi yaitu sebanyak 36,8% (2007), sebanyak 35,6% (2010), sebanyak 37,2% (2013) dan sebanyak 30,8% (2018). Walaupun terjadi penurunan prevalensi balita pendek (stunting) dalam kurun waktu 2013 dan 2018, namun stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dianggap berat (30%-39%) (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Hasil Penelitian oleh penulis di Sulawesi Utara pada tahun 2024 pada variabel pengetahuan didapatkan hasil terdapat peningkatan rata rata pengetahuan ibu dalam stimulasi perkembangan anak dengan stunting sebelum dan sesudah diberikan edukasi dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan tingkat kemaknaan 0,001 ($p < 0,005$). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh peran edukasi dalam meningkatkan pengetahuan ibu dalam stimulasi perkembangan anak dengan stunting

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang stunting masih dalam kategori kurang memadai pada sekitar 108 responden (54.8%) dari total 197 orang responden (Hendrawati& Witdiawati,2020). Rendahnya tingkat pengetahuan ibu akan berdampak pada kesehatan anak yang merujuk pada peningkatan risiko terjadinya stunting, hal ini didasari dimana wawasan seseorang mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku manusia (Arnita, Rahmadhani & Sari,2020). Beberapa hasil studi menunjukkan Ibu yang memiliki pemahaman yang kurang mengenai stunting akan cenderung mempunyai kesadaran yang lebih rendah terhadap perilaku- perilaku pencegahan jika dibandingkan dengan ibu yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting (Kuswanti& Azzahra,2022).

Pengetahuan ibu yang kurang memadai terhadap stunting menjadi salah satu faktor tidak langsung yang berperan terhadap tingginya insiden stunting pada anak usia dini. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang konsep stunting, pentingnya menyiapkan makanan dengan gizi seimbang, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil tinjauan berbagai literatur, pada mayoritas penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar ibu memiliki pemahaman yang kurang memadai tentang stunting (Rahmandiani, Astuti, Susanti, Handayani, & Didah, 2019; Hendrawati& Witdiawati,2020; Mirayanti & Juanamasta, 2020; Putri,Mardiah,&Yulianita,2021; AL,Hasanuddin,&Sulaeman, 2021; Sidabuke, Parapat, & Lumbantoruan, 2021; Muzayyaroh,2021; Wulandini, Efni, & Marlita, 2020; Rahmawati, Nurmawati, & Sari, 2019).

Selain pengetahuan yang kurang memadai tentang stunting, studi lain juga mengukur gambaran pengetahuan

ibu tentang stimulasi perkembangan anak usia 36-48 bulan di wilayah kerja Ikrur Koto Kota Padang dimana menunjukkan hasil pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan anak usia 3-4 tahun pada kelompok intervensi 1 sebanyak 23 orang (56,1%) memiliki pengetahuan kurang dan pada kelompok intervensi 2 sebanyak 32 orang (78%) memiliki pengetahuan kurang (Aprianti, Neherta, Dewesita, 2023).

Pengetahuan ibu merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan kepada anak. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak sangat membutuhkan perhatian yang cukup untuk membantu perkembangan anak yang optimal. Dengan pengetahuan yang baik yang dimiliki ibu, ibu akan memiliki berbagai informasi meliputi bagaimana pola asuh anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anak, dan pengetahuan bagaimana memberikan stimulasi yang sesuai usia pada anak agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman dan pengetahuan yang baik dapat diperoleh dari suatu proses pendidikan yang baik dan melalui proses serta metode-metode tertentu sehingga orang bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, pemahaman dan cara berperilaku yang sesuai dengan kebutuhan (Susanti and Adawiyah, 2020).

Ibu sebagai pengasuh terdekat seorang anak harus mengetahui lebih banyak proses pertumbuhan dan perkembangan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses itu. Pengetahuan ibu tentang perkembangan anak sangatlah penting karena dapat mengarahkan ibu untuk lebih berinteraksi dengan anak sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan anak. Ibu yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak

cenderung akan menciptakan lingkungan yang sesuai untuk munculnya kemampuan anak (Pramusinta, 2019).

Stimulasi perkembangan yang tidak optimal sesuai tahap perkembangan akan berdampak pada gangguan kemampuan berbicara dan berbahasa ekspresif pada anak dalam fase belajar bicara, jumlah kosa kata yang dimiliki dapat jauh tertinggal daripada teman-teman yang sebayanya, sehingga dikemudian hari akan mengalami gangguan dalam pemahaman bahasa (semantik) yang menyebabkan rendahnya skor verbal IQ, pada gangguan menetap seperti autisme skor verbal IQ yang rendah disertai juga dengan skor performansi IQ yang lebih rendah daripada normal (Indah, 2017). Gangguan perkembangan bicara dan bahasa dapat merupakan karakteristik sekunder gangguan fisik dan perkembangan yang lain (gangguan motorik kasar, motorik halus, sosialisasi kemandirian) (Hartanto, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Siwati dkk 2022 pada penelitian berjudul Hubungan Status Gizi Dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Usia 12-36 Bulan Terhadap Stunting di Desa Karangawen kecamatan Tambakromo diketahui bahwa anak yang mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang cukup dari orang tua atau keluarga, maka tidak mengalami stunting sedangkan yang kurang mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang baik anak dapat berpotensi mengalami stunting sehingga selain faktor status gizi, kebersihan, stimulasi tumbuh kembang juga berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak usia 12-36 bulan.

Edukasi dalam peningkatan pengetahuan ibu akan stimulasi perkembangan pada anak perlu dilakukan dalam upaya pencegahan stunting. Sehingga diperlukan kontribusi tenaga kesehatan khususnya perawat dalam peningkatan promosi kesehatan dan edukasi pengetahuan ibu sebagai

upaya pencegahan stunting. Tenaga Kesehatan dapat berperan dalam peningkatan kemampuan ibu melalui pemberian edukasi dengan berbagai metode.

B. Sikap

Hasil Penelitian oleh penulis di Sulawesi Utara pada tahun 2024 menunjukkan terdapat perbedaan skor sikap antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Dengan tingkat kemaknaan 0,001 ($p < 0,005$) dari data tersebut, terlihat adanya perbedaan skor sikap antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ibu yang tergabung dalam kelompok intervensi, yang mendapatkan paparan video edukasi mengenai stimulasi perkembangan, memiliki skor sikap yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman pada ibu mengenai pentingnya stimulasi perkembangan pada anak, terutama anak yang mengalami stunting.

Sikap (attitude) merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesenangan atau tidak senangnya terhadap suatu objek. Objek itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif. Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya netral (Darmiati, 2017).

Attitude atau sikap ini di dalamnya sedikitnya mempunyai tiga aspek pokok, yaitu: Pertama, Aspek Kognitif, aspek yang berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran yang merupakan pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek

atau sekelompok obyek. Kedua, Aspek Afektif, aspek yang merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipasti dan sebagainya yang ditujukan pada obyek obyek tertentu. Dan Ketiga Aspek Konatif, Suatu aspek yang berwujud suatu proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada obyek. Dengan demikian, pembentukan kompetensi sikap ini bekerja secara simultan dengan pembentukan kompetensi pengetahuan dan kompetensi lainnya yang berkaitan dan dilakukan dalam waktu pendidikan berlangsung.

Antara attitude dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang jelas terdapat perbedaan walaupun attitude (sikap) itu hanya merupakan sikap pandangan saja. Suatu pengetahuan mengenai suatu obyek tertentu baru akan menjadi attitude, bila pengetahuan tersebut disertai dengan kesiapan dengan bertindak yang sesuai dengan obyeknya. Jadi attitude ini merupakan tindak lanjut dari pengetahuan seseorang tentang suatu obyek. Attitude juga berbeda dengan kebiasaan tingkah laku, kebiasaan tingkah laku ini hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis, yang berlangsung dengan sendirinya yang maksudnya memperlancar atau mempermudah hidup saja. Akan tetapi mungkin juga terjadi banyak attitude itu dinyatakan oleh kebiasaan tingkah laku tertentu (Pasundan, 2019).

Domain yang penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang adalah pengetahuan. Pengetahuan seseorang akan baik apabila mendapatkan informasi yang baik juga sehingga informasi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung memiliki sikap positif dimana mereka akan melaksanakan

atau berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Menurut penelitian, didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap ibu terhadap tumbuh kembang balita. Ibu yang memiliki informasi yang baik tentang tumbuh kembang akan mengakibatkan ibu memiliki sikap yang mendukung terhadap stimulasi tumbuh kembang anaknya (Siregar ES, 2021)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Katharina & Iit (2018) dimana yang mempengaruhi perkembangan anak adalah sikap. Penelitiannya mengungkapkan ibu yang bersikap mendukung akan selalu sadar memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya hingga anak bisa berkembang secara optimal sesuai usianya. Hasil tersebut berbeda dengan kesimpulan penelitian Wijayanti & Edmiandini (2017) bahwa tidak ada hubungan sikap ibu tentang stimulasi perkembangan dengan tahap perkembangan anak usia 3-4 tahun. Kedua pernyataan diatas saling bertentangan, maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut.

Sikap ibu sangat memengaruhi perilaku ibu dalam melakukan stimulasi perkembangan anak. Sikap yang positif biasanya terbentuk melalui pemahaman yang baik tentang pentingnya stimulasi perkembangan anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Edukasi, khususnya yang menggunakan media audiovisual seperti video, terbukti efektif dalam meningkatkan sikap ibu.

C. *Self Efficacy*

Hasil Penelitian oleh penulis di Sulawesi Utara pada tahun 2024 terdapat perbedaan skor *self efficacy* antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Sehingga

dapat dikatakan video edukasi meningkatkan Self efikasi ibu dalam melakukan stimulasi perkembangan.

Definisi tradisional tentang efikasi diri dalam literatur didasarkan pada teori Bandura; Bandura (1989, 1997), yang mendefinisikan self efikasi sebagai keyakinan atau kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugas tertentu dan menangani hambatan dengan cara yang memungkinkan mereka untuk berhasil memenuhi harapan mereka. Secara khusus berkenaan dengan pengasuhan anak, Maturana 2022 mendefinisikannya sebagai keyakinan orang tua terhadap kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul berkaitan dengan pengasuhan anak, dan untuk mendorong perkembangan dan adaptasi positif darianak-anak mereka.

Self efficacy juga diartikan sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuan yang dimiliki dan mengarah ketindakan yang kemudian berpengaruh terhadap berbagai kejadian dalam kehidupan. Konsep secara umum *self efficacy* diartikan sebagai keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menunjukkan keberhasilan pada suatu perilaku. (Empati, Rahmawati and Ratnaningsih, 2018).

Parenting Self-Efficacy adalah perasaan memiliki kemampuan dalam peran *parenting*. *Parenting Self-Efficacy* sebagai keyakinan orang tua terhadap kemampuannya dalam mempengaruhi anak dan lingkungan yang akan memberikan keberhasilan dan perkembangan anak. *Parenting Self-Efficacy* sebagai estimasi penilai mandiri sendiri (self referent) terhadap kemampuan menjalankan peran orangtua untuk memberikan pengaruh positif ke dalam tingkah laku dan perkembangan anak mereka (Korua, Arifin, Laiya, 2023).

Pola asuh merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dengan anak dan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Syahrul & Nurhafizah, 2021). Rendahnya tingkat *self-efficacy* atau kurangnya rasa percaya diri ibu dalam mengasuh anak juga disebabkan oleh kelompok status sosial ekonomi rendah, yang umumnya mengalami kekurangan sumber daya material yang memadai, seperti kesulitan makan, ketidakstabilan perumahan, dan tidak adanya asuransi kesehatan. Adanya tekanan ekonomi tersebut menyebabkan orang tua sulit memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anak-anaknya dan seringkali ditemukan menjadi kendala utama bagi orang tua untuk melaksanakan tugas pengasuhan anak dengan penuh perhatian (Wandani et al., 202).

Dengan demikian, apabila *self-efficacy* ibu rendah, maka gizi juga akan rendah, dan aktivitas fisik yang menyehatkan bagi bayi pun akan rendah. Sebaliknya, apabila *self-efficacy* ibu tinggi, maka akan mampu meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat dan mengasuh bayi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam merawat anak dan memberikan stimulasi untuk memantau perkembangan kognitif pada anak (Vega et al., 2019).

Orang tua dengan efikasi diri yang tinggi umumnya lebih mampu membantu anaknya berkembang dengan baik dibandingkan dengan orang tua dengan efikasi diri yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk meningkatkan *parenting self-efficacy* mereka untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka dengan lebih baik. Dampak dari kurangnya pengetahuan tentang *parenting self efficacy* akan menghambat perkembangan

dari anak itu sendiri. Kurangnya *parenting self-efficacy* orang tua dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak, seperti kurangnya dukungan emosional, pengaturan dan konsistensi yang kurang, kurangnya stimulasi dan dorongan, komunikasi yang tidak efektif, dan rendahnya kualitas hubungan orang tua-anak adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Penting bagi orang tua untuk memperkuat keyakinan diri mereka sebagai orang tua melalui pendidikan, dukungan sosial, dan peningkatan pemahaman tentang perkembangan anak untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung stimulasi perkembangan yang sehat dan positif bagi anak. (Korua, Arifin, Laiya, 2023).

Hal yang dapat meningkatkan *self-efficacy* ibu juga dapat dipengaruhi oleh keterlibatan ayah yang suportif untuk bekerja sama dalam hal pengasuhan anak (Putri Dena Laksmi et al., 2018). Proses tumbuh kembang dimulai sejak masa bayi, dan ini merupakan proses yang sangat penting, karena pada masa ini proses tumbuh kembang menentukan masa depan bayi secara fisik, mental, dan perilaku. Pertumbuhan dan perkembangan pada setiap tahap usia tidak selalu sama, tergantung pada faktor keturunan, konsumsi gizi, perlakuan orang tua dan orang dewasa, serta lingkungan (Hapsari et al., 2019).

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai dalam waktu lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif pada anak, sehingga diperlukan pola asuh yang tepat (Yadika et al., 2019). Pengetahuan dan keterampilan ibu akan mempengaruhi rasa percaya dirinya dalam menjalankan peran pengasuhan anak,

yang disebut dengan *maternal self-efficacy*. Dengan demikian sangat penting bagi seorang ibu untuk memiliki rasa percaya diri atau *self-efficacy* yang tinggi dalam mengasuh anak, terutama dalam memantau dan menstimulasi perkembangan kognitif pada anak. Jika *self-efficacy* ibu rendah, maka rata-rata gizi yang diberikan kepada anak akan kurang dan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya, jika *self-efficacy* ibu tinggi, maka akan mampu meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam mengasuh dan membesarkan anak dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya (Gumela & Tangpukdee, 2022). Karena keyakinan ibu tentang seberapa baik dirinya mampu menjadi ibu merupakan komponen yang diperlukan untuk memahami keyakinannya, perilaku mengasuh yang sebenarnya, dan interaksi antara ibu dan anak karena dampak dari keyakinan pengasuhan tersebut memiliki dampak terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Menurut penelitian sebelumnya Penelitian yang berbasis pada proses kognitif, efikasi diri mampu mengatur kognisi manusia. Efikasi diri yang kuat yang dirasakan akan membuat seseorang menetapkan tujuan terbaik dan akan berusaha untuk tetap berkomitmen pada tujuan tersebut (Kurniawati & Kasih, 2022).

BAB 5

PENUTUP

Dalam monograf penelitian ini, kami telah mengeksplorasi dampak multifaset dari pendidikan berbasis video dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri para ibu dalam merangsang perkembangan anak, khususnya dalam konteks stunting. Temuan yang disajikan di seluruh karya ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh para ibu yang terinformasi dan berdaya dalam mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Penerapan intervensi pendidikan video secara signifikan meningkatkan pemahaman para ibu tentang tonggak perkembangan anak dan kebutuhan gizi anak-anak mereka. Peningkatan pengetahuan ini sangat penting, karena membekali para ibu dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan dan gizi anak-anak mereka.

Penelitian ini mengungkapkan perubahan penting dalam sikap di antara para ibu terhadap praktik pengasuhan anak. Dengan terlibat dengan konten video yang menyoroti strategi yang berhasil untuk merangsang perkembangan anak, para ibu melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam kemampuan mengasuh mereka dan pandangan yang lebih positif tentang peran mereka dalam memerangi stunting.

Salah satu hasil paling signifikan dari intervensi edukasi video adalah peningkatan efikasi diri di antara para ibu. Peserta menyatakan keyakinan yang lebih besar pada kapasitas mereka untuk menerapkan praktik perkembangan yang efektif, yang

merupakan komponen penting dalam membina lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak yang sehat.

Implikasi dari temuan ini sangat mendalam. Dengan memanfaatkan kekuatan video sebagai alat edukasi, inisiatif kesehatan masyarakat dan program komunitas dapat secara efektif menjangkau dan melibatkan para ibu, khususnya di populasi yang kurang terlayani di mana metode pendidikan tradisional mungkin tidak memadai.

Konten video dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform, sehingga dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Skalabilitas ini menghadirkan peluang untuk mengatasi masalah yang meluas seperti stunting dalam skala yang lebih luas. Menyesuaikan konten video untuk mencerminkan budaya dan praktik lokal dapat meningkatkan keterkaitan dan efektivitas, memastikan bahwa pesan beresonansi dengan audiens target.

Meskipun monograf ini telah memberikan wawasan berharga tentang dampak pendidikan berbasis video, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk memperdalam pemahaman kita. Studi lebih lanjut perlu mempertimbangkan desain longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang pendidikan video terhadap pengetahuan ibu dan hasil perkembangan anak. Memperluas penelitian untuk mencakup berbagai kelompok demografi akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi spesifik, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih disesuaikan. Menyelidiki efek sinergis pendidikan video yang dikombinasikan dengan intervensi kesehatan lain (seperti dukungan nutrisi atau akses layanan kesehatan) dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi stunting.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti potensi transformatif pendidikan berbasis video dalam memberdayakan

ibu untuk meningkatkan perkembangan anak-anak mereka dan memerangi stunting. Dengan berinvestasi dalam strategi pendidikan inovatif yang memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting dan membina masyarakat yang lebih sehat. Perjalanan menuju peningkatan kesehatan anak masih berlangsung, tetapi dengan para ibu yang terinformasi dan berdaya sebagai pemimpinnya, kita dapat membuat langkah signifikan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sembari melangkah maju, mari kita terus mengadvokasi sumber daya pendidikan yang dapat diakses yang memberdayakan semua ibu, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children: A cross-sectional study in the public health center of Jember, Indonesia. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- (IDAI), Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2014. "Memerah Dan Menyimpan Air Susu Ibu (ASI)." : 9–11.
- Agha, A., White, F., Younus, M., Kadir, M. M., Ali, S., & Fatmi, Z. (2007). Eight key household practices of Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) amongst mothers of children aged 6 to 59 months in Gambat, Sindh, Pakistan. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 57(6), 288–293. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-38549126879&partnerID=40&md5=50e601e83f1ece8312de99d64583ac79>
- Ain, H., Arief, Y. S., Krisnana, I., & Astuti, E. S. (2024). Efforts to Prevent Stunting in Children Aged 0-24 Months: An Integrative Review. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 20(5), 353–366. <https://doi.org/10.47836/mjmhs20.5.42>
- AL, J. P., Hasanuddin, I., & Sulaeman, S. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Umur 12-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan Panrita Husada*, 6(1), 75-85.
- Alexander, S., Ostfeld, R. J., Allen, K., & Williams, K. A. (2017). A

plant-based diet and hypertension. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 327–330.
<https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.014>

Aljuraiban, G., Chan, Q., Gibson, R., Stamler, J., Daviglius, M. L., Dyer, A. R., Miura, K., Wu, Y., Ueshima, H., Zhao, L., Van Horn, L., Elliott, P., & Oude Griep, L. M. (2020). Association between plant-based diets and blood pressure in the INTERMAP study. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(2), 133–142.
<https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000077>

Allender, J. A., & Spardley, B. W. (2011). *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.

Altobelli, L. C., Cabrejos-Pita, J., Penny, M., & Becker, S. (2020). A cluster-randomized trial to test sharing histories as a training method for community health workers in Peru. *Global Health Science and Practice*, 8(4), 732–758.
<https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00332>

Anderson, E., & Mc Farlane, J. (2004). *Community As Partner: Theory and Practice in Nursing* (4th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.

APRIANTI, D., NEHERTA, M., & DESWITA, D. (2023). Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Stimulasi Perkembangan Anak Usia 36-48 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ikur Koto Kota Padang. *Jurnal Ners*, 7(1), 40-47.

Aristi, D. L. A., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., & Siswoyo, S. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 53–60.

<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2741>

- Arnita, S., Rahmadhani, D. Y., & Sari, M. T. (2020). Hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan upaya pencegahan stunting pada balita di wilayah kerja puskesmas simpang kawat kota Jambi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9(1), 7-14.
- Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7-12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>
- Astuti, Sri, Ginna Megawati, and Samson CMS. 2018. "Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 7(3): 185-88. <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/20034> (April 24, 2023).
- Bagasraga, G., Muzakki, H., Rahman, M. R., Degriyanto, E., & Hasugian, L. P. (2023). Information system design for stunting examination in children at Wijaya Kusumah healthcare center. In L. Warlina, H. Maulana, & S. Luckyardi (Eds.), *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2882, Issue 1). American Institute of Physics Inc. <https://doi.org/10.1063/5.0175677>
- Bandura, A., & Wessels, S. (1997). Self-efficacy (pp. 4-6). Cambridge: Cambridge University Press.
- Berk, L. E. (2018). *Child Development* (9th ed.). Pearson.
- Bettinelli, Maria Enrica. 2012. "Breastfeeding Policies and

Breastfeeding Support Programs in the Mother ' s Workplace." *The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine* 25: 81–82.

Bhutta, Z. A., & Das, J. K. (2013). Evidence-based interventions for improving maternal and child nutrition and health. *The Lancet*, 382(9890), 452–465. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60971-6

Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)

Bigool, M. (2024). Effects of free maternal healthcare on stunting in children under five years of age: Evidence from Ghana. *Development Policy Review*, 42(4). <https://doi.org/10.1111/dpr.12771>

Black, M. M., & Victora, C. G. (2018). Maternal and child nutrition and early child development. *The Lancet*, 390(10106), 2307–2309. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32823-7

Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>

Damiati, dkk. (2017), *Perilaku Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.

Danso, Janet. 2014. "Examining the Practice of Exclusive Breastfeeding among Professional Working Mothers in Kumasi Metropolis of Ghana." *International Journal of Nursing* 1(1): 11–24.

- Darwis, D., Abdullah, R., Amaliah, L., Bohari, B., & Rahman, N. (2021a). Experience of mother in taking care of children with stunting at Majene regency, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 33–38. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5521>
- Darwis, D., Abdullah, R., Amaliah, L., Bohari, B., & Rahman, N. (2021b). Experience of mother in taking care of children with stunting at Majene regency, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 33–38. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5521>
- de Hoop, T., Fallon, S., Yunus, F. M., Munrat, S., Jolly, S. P., Sehrin, F., Aktar, B., A Ghani, R. B., & Sennett, J. (2020). Mothers' education and the effectiveness of nutrition programmes: evidence from a matched cross-sectional study in rural Bangladesh. *Journal of Development Effectiveness*, 12(4), 279–297. <https://doi.org/10.1080/19439342.2020.1828998>
- Del Carmen Casanovas, M., Mangasaryan, N., Mwadime, R., Hajeebhoy, N., Aguilar, A. M., Kopp, C., Rico, L., Ibiert, G., Andia, D., & Onyango, A. W. (2013). Multi-sectoral interventions for healthy growth. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 46–57. <https://doi.org/10.1111/mcn.12082>
- Dewi, Uke Maharani, and Yunik Windarti. 2017. "Efektivitas Pompa Air Susu Ibu: Studi Kasus Pada Ibu Bekerja." *Jurnal Sainmed* 10(2): 42–46.
- Dinengsih, Sri, and Nurzakirah Hakim. 2020. "Pengaruh Metode Ceramah Dan Metode Aplikasi Berbasis Android Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kebidanan* 6(4): 515–22.

- Dinkes Jawa Timur. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 1–73. www.dinkesjatengprov.go.id
- Dolifah, D., Setiadi, D. K., Rahmat, D. Y., & Supriyadi, T. (2021). Providing education for a mother in stunting prevention: A collaborative study through action research. *Universal Journal of Public Health*, 9(2), 83–93. <https://doi.org/10.13189/ujph.2021.090207>
- Dukhi, Natisha. 2020. "Global Prevalence of Malnutrition: Evidence from Literature." *Malnutrition*.
- Edae, B. S., Yazew, T., Disasa, H. D., & Kuyu, C. G. (2024). Growth Monitoring and Promotion Service Utilization and Associated Factors Among Mothers/Caregivers of Children 0–23 Months in Sude District, Southeast Ethiopia. *Maternal and Child Nutrition*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13769>
- Elisaria, E., Mrema, J., Bogale, T., Segafredo, G., & Festo, C. (2021). Effectiveness of integrated nutrition interventions on childhood stunting: a quasi-experimental evaluation design. *BMC Nutrition*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-021-00421-7>
- Fahriani, Reni, Rinawati Rohsiswatmo, and Aryono Hendarto. 2014. "Faktor Yang Memengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Cukup Bulan Yang Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)." *Sari Pediatri* 15(6).
- Faridah, F., Anies, A., Kartasurya, M. I., & Widjanarko, B. (2024a). Online educational intervention: Improving maternal knowledge and attitudes in providing developmental stimulation for stunting toddlers. *Narra J*, 4(1). <https://doi.org/10.52225/narra.v4i1.591>

- Faridah, F., Anies, A., Kartasurya, M. I., & Widjanarko, B. (2024b). Online educational intervention: Improving maternal knowledge and attitudes in providing developmental stimulation for stunting toddlers. *Narra J*, 4(1). <https://doi.org/10.52225/narra.v4i1.591>
- Fatmaningrum, Widati et al. 2022. "Analisis Situasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting Dengan Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting." *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)* SP(1): 139–44. <https://unair.ac.id/upaya-percepatan-penurunan-stunting-dengan-pendekatan-keluarga-berisiko-stunting/> (April 24, 2023).
- Ganju, A., Satyan, S., Tanna, V., & Menezes, S. R. (2021). AI for Improving Children's Health: A Community Case Study. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3. <https://doi.org/10.3389/frai.2020.544972>
- Gibson, R. S. (2015). *Principles of Nutritional Assessment* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Giyaningtyas, I. J., Hamid, A. Y. S., & Daulima, N. H. C. (2019). Holistic response of mother as caregiver in treating stunting children. *Pakistan Journal of Medical and Health Sciences*, 13(3), 928–932. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076342751&partnerID=40&md5=13da0e529c2824837a21d6960aa1b9f0>
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2014). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), 60–70. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60032-4

- Grauduszus, M., Koch, L., Wessely, S., & Joisten, C. (2024). School-based promotion of physical literacy: a scoping review. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1322075>
- Guldan, G. S., & Zhang, M. (2018). Stimulation of child development and prevention of stunting. *Food and Nutrition Bulletin*, 39(2), 295-309. doi: 10.1177/0379572118774141
- Gumelar, W. R., & Tangpukdee, J. (2022). The Effect of Nutrition Education Based on Local Foods on Mothers' Knowledge and Anthropometry of Malnutrition Children Aged 6 to 21 Months. *The Malaysian Journal of Nursing (MJN)*, 14(1), 53-58.
- Gupta, A. K., Mongia, M., & Garg, A. K. G. (2018). A descriptive study of behavioral problems in schoolgoing children. *Industrial Psychiatry Journal*, 195-201. <https://doi.org/10.4103/ipj.ipj>
- Halder, S., & Kejriwal, S. (2016). Nutritional awareness of mothers in relation to nutritional status of the preschool children. *Early Child Development and Care*, 186(9), 366-1377.
- Handayani, D., Kusuma, E., Puspitasari, H., & Nastiti, A. D. (2022). The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Coastal Areas. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(3), 755-764. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i3.967>
- Harahap, R. A., Rochadi, R. K., & Sarumpae, S. (2018). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki Dewasa Awal (18-40 Tahun) Di Wilayah Puskesmas Bromo Medan Tahun 2017. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 68-73.

<https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.951>

- Harris, J., & Lortie, M. (2021). Implementing early childhood development programs for at-risk populations. *Journal of Early Childhood Research*, 19(3), 213-227. doi: 10.1177/1476718X211014327
- Hartanto, W. S. (2018). Deteksi keterlambatan bicara dan bahasa pada anak. *Cermin Dunia Kedokteran*, 45(7), 545-549.
- Hartinger, S. M., Nuño, N., Hattendorf, J., Verastegui, H., Karlen, W., Ortiz, M., & Mäusezahl, D. (2020). A factorial cluster-randomised controlled trial combining home-environmental and early child development interventions to improve child health and development: Rationale, trial design and baseline findings. *BMC Medical Research Methodology*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12874-020-00950-y>
- Haryanti, F., Hartini, S., Andarwati, F., Risnawati, H., Pratiwi, A. N., Kusumawati, A. S., Cahyani, R. D., & Lusmilasari, L. (2024). Maternal knowledge on nutritional-focused nurturing care and associated factors among women with stunted children aged 6-23 months in Yogyakarta, Indonesia: A cross-sectional study. *Belitung Nursing Journal*, 10(4), 472-480. <https://doi.org/10.33546/bnj.3481>
- Has, E. M. M., Krisnana, I., & Efendi, F. (2024). Enhancing Maternal Caregiving Capabilities Model to Prevent Childhood Stunting: A UNICEF-Inspired Model. *SAGE Open Nursing*, 10. <https://doi.org/10.1177/23779608231226061>
- Hastuti, A. P., Sukartini, T., Arief, Y. S., Nursalam, N., Roesardhyati, R., Kurniawan, A. W., & Suprawoto, D. N. (2024). Women's empowerment based on self-regulated

learning as mother's ability to fulfill nutrition in stunted children. *Medical Journal of Malaysia*, 79(1), 28–33. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85183783118&partnerID=40&md5=7c5c599d0c6f2b7c21e93e0fc5fa6e71>

Hendrawati, S., KH, F. H., & Witdiawati, W. (2020). Knowledge of mother toddlers about stunting. *Riset Informasi Kesehatan*, 9(2), 115-125.

Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>

Hoddinott, J., & Kimenyi, M. S. (2020). Nutritional interventions for stunted children. *Annual Review of Nutrition*, 40, 125-151. doi: 10.1146/annurev-nutr-082119-051744

Homsy, M. B., & Hussein, L. A. (2013). National Agency Systems. In *Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199922994.003.0021>

Huriah, T., Lestari, A. A., Rahmawati, A., & Prasetyo, Y. B. (2021). The integrated intervention of early childhood education and stunting prevention program in increasing pre-school age children's food intake. *Bali Medical Journal*, 10(3 Special Issue ICONURS), 1329–1332. <https://doi.org/10.15562/bmj.v10i3.2914>

Ikasari, F. S., Maria, I., Nugraha, F. S., Abdillah, A. R., Kirana, C. I. A., & Wirandi, M. (2024). Mother's Experience of Caring for Children With Stunting In The Riverside of Banjar

Regency. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 7(11), 2666–2682.
<https://doi.org/10.56338/mpпки.v7i11.6231>

Indah, R. N. (2017). Gangguan berbahasa: Kajian pengantar.

Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di kecamatan panti kabupaten jember. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.

Javid, N., & Pu, C. (2020). Maternal stature, maternal education and child growth in Pakistan: a cross-sectional study. *AIMS Public Health*, 7(2), 380–392.
<https://doi.org/10.3934/publichealth.2020032>

Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*, 29(1), 16–21.
<https://doi.org/10.1097/MNH.0000000000000574>

Kamisutara, Made. 2017. Penerapan Teknologi Informasi Pada Kondisi Early Warning Dalam Meminimalkan Tingkat Kematian Ibu Hamil Dan Bayi. Surabaya: Narotama University Press.

Katharina, T., & Iit, K. (2018). The Relationship Between Mother's Knowledge and Attitudes Toward Growth and Development of Children Aged 0-24 Months. *Journal of Midwifery*, 7(2), 265351.

Kavosi, E., Rostami, Z., Kavosi, Z., Nasihatkon, A., Moghadami, M., & Heidari, M. (2014). Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province. *Iran Int J Health Policy*

Manag, 3(2), 71–76.

Kemenkes RI. (2016). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Vol. 21, Issue 1). Kementerian Kesehatan RI. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Kementerian Kesehatan RI. 2018. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI.

Kementerian Kesehatan, RI. 2022. BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Korua, N. A., Arifin, I. N., & Laiya, S. W. (2023). Peran Parenting Self Efficacy Orang Tua Pada Perkembangan Anak Usia Dini Di Kelompok B. *Student Journal of Early Childhood Education*, 3(2), 163-177.

Kurniawati, N., & Kasih, D. (2022). Hubungan Efikasi Diri Pengasuhan Ayah dengan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di Kecamatan Ciledug Tangerang Banten. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 4550-4556.

Kusumasari, D., & Subhiyakto, E. R. (2024). Development of Website-Based Stunting Prevention Educational Media Services (Case Study: UPT Puskesmas Tirto Pekalongan). *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology*, 6(2). <https://doi.org/10.26877/asset.v6i2.18530>

Kuswanti, I., & Azzahra, S. K. (2022). Hubungan pengetahuan ibu tentang pemenuhan gizi seimbang dengan perilaku pencegahan stunting pada balita. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1).

- Lee, L., & Liu, Y.-S. (2021). Training effects and intelligent evaluated pattern of the holistic music educational approach for children with developmental delay. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph181910064>
- Léniz-Maturana, L., Vilaseca, R., & Leiva, D. (2022). Maternal self-efficacy and emotional well-being in Chilean adolescent mothers: the relationship with their children's social-emotional development. *PeerJ*, 10, e13162.
- Mahmudiono, T., Al Mamun, A., Nindya, T. S., Andrias, D. R., Megatsari, H., & Rosenkranz, R. R. (2018). The effectiveness of nutrition education for overweight/obese mother with stunted children (NEO-MOM) in reducing the double burden of malnutrition. *Nutrients*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/nu10121910>
- Mangundap, Selvi Alfrida et al. 2022. "Health Cadre Education on Providing Stunting Risk Family Assistance toward Children." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)* 10(G): 306–10. <https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8548> (April 24, 2023).
- Martinez, B., Flood, D., Cnop, K., Guzman, A., & Rohloff, P. (2019). Improving infant and young child nutrition in a highly stunted rural community: A practical case study from guatemala. In *Handbook of Famine, Starvation, and Nutrient Deprivation: From Biology to Policy* (pp. 2381–2398). Springer International Publishing. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078212187&partnerID=40&md5=db052f4d28123b493df63bfd5a95bee6>

- Mazida, Z., Noveyani, A. E., & Prasetyowati, I. (2024). MOTHER'S HEALTH LITERACY WITH STUNTING INCIDENCE OF TODDLERS IN JEMBER. *Indonesian Journal of Public Health*, 19(2), 381–389. <https://doi.org/10.20473/ijph.v19i2.2024.381-389>
- Miller, M. A., & McCune, K. R. (2017). Stimulation and early childhood development: Interventions for the management of stunting. *Journal of Pediatrics and Child Health*, 53(5), 459-466. doi: 10.1111/jpc.13437
- Mirayanti, N. K. A., & Juanamasta, I. G. (2020). Knowledge and attitude of Mothers about Stunting in Banjar Pengukuh Peguyangan Kangin Village Denpasar. *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 7(3), 320-325.
- Muzayyarah, M. (2021). Tingkat Pengetahuan Ibu Balita Tentang Stunting. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 8(2), 81-92.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). Early years: Promoting the health and development of children from birth to age 5. NICE. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/ng56>
- Ohonba, A., Ngepah, N., & Simo-Kengne, B. (2019). Maternal education and child health outcomes in South Africa: A panel data analysis. *Development Southern Africa*, 36(1), 33–49. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1456908>
- Paintal, K., & Aguayo, V. M. (2016). Feeding practices for infants and young children during and after common illness. Evidence from South Asia. *Maternal and Child Nutrition*, 12, 39–71. <https://doi.org/10.1111/mcn.12222>
- Pasundan, T. (2019). Memahami Pembentukan Sikap (Attitude) Dalam Pendidikan Pelatihan. *Jurnal Diklat*

Keagamaan, 13.

- Permatasari, T. A. E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W., Suryaalamasah, I. I., & Hermiwahyoeni, Z. (2021). The effect of nutrition and reproductive health education of pregnant women in Indonesia using quasi experimental study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03676-x>
- Piper, J. D., Mazhanga, C., Mwapaura, M., Mapako, G., Mapurisa, I., Mashedze, T., Munyama, E., Kuona, M., Mashiri, T., Sibanda, K., Matemavi, D., Tichagwa, M., Nyoni, S., Saidi, A., Mangwende, M., Chidhanguro, D., Mpofu, E., Tome, J., Mutasa, B., ... Prendergast, A. J. (2023). The Sanitation Hygiene Infant Nutrition Efficacy (SHINE) Trial: Protocol for school-age follow-up. *Wellcome Open Research*, 8. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.19463.1>
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(1), 4-10. doi: 10.1179/2046905513Y.0000000072
- Putri, M. M., Mardiah, W., Yulianita, H., & Keberawatan, F. (2021). Gambaran Pengetahuan Ibu Balita Tentang Stunting. *Journal of Nursing Care*, 4(2).
- Rachmawati, U. A., Suherlan, E., Windriyani, P., Pratiwi, P. S., Prasetyo, R., Ghammi, K., Alawiyah, M., & Fajriyanti, S. (2022). SiCenting+: An Information System for Monitoring the Stunted Growth and Nutritional Status of Children in Pandeglang Regency. 2nd IEEE International Conference on Advanced Technologies in Intelligent Control, Environment, Computing and Communication Engineering, ICATIECE 2022.

<https://doi.org/10.1109/ICATIECE56365.2022.10046915>

Rahmandiani, R. D., Astuti, S., Susanti, A. I., Handayani, D. S., & Didah, D. (2019). Hubungan pengetahuan ibu balita tentang stunting dengan karakteristik ibu dan sumber informasi di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 5(2), 74-80.

Rahmawati, A., Nurmawati, T., & Sari, L. P. (2019). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang stunting pada balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389-395.

Rahmawati, R. A., & Ratnaningsih, I. Z. (2020). Hubungan antara parenting self-efficacy dan konflik pekerjaan-keluarga pada ibu bekerja yang memiliki anak usia sekolah dasar di pt."x" cirebon. *Jurnal Empati*, 7(2), 582-590.

Rania, R. L., Lala, H., & Djuwadi, G. (2024). The Efforts of Toddler Integrated Healthcare Center Cadres in Increasing Mother Visits to Integrated Healthcare Center Kartini Bandungrejosari. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(6), 1544–1550.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v7i6.5244>

Rodrigo, Ranmali, Lisa H Amir, and Della A Forster. 2018. "Review of Guidelines on Expression , Storage and Transport of Breast Milk for Infants in Hospital , to Guide Formulation of Such Recommendations in Sri Lanka." *BMC Pediatrics* 18(271): 1–9.

Sandjojo, Eko Putro. 2017. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sari, Putri Nilam. 2015. "Meningkatkan Kesuksesan Program ASI

- Eksklusif Pada Ibu Bekerja Sebagai Upaya Pencapaian MDGs." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9(2): 93–97.
- Sarwar, A., Jadoon, A. K., Chaudhry, M. A., Latif, A., & Javaid, M. F. (2024). How important is parental education for child nutrition: analyzing the relative significance of mothers' and fathers' education. *International Journal of Social Economics*, 51(10), 1209–1225. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2023-0483>
- Sidabuke, I., Parapat, F., & Lumbantoruan, M. (2021). PENGETAHUAN IBU BALITA TENTANG STUNTING DI KELURAHAN PEKAN TANJUNG MORAWA. *Jurnal Health Reproductive*, 6(2).
- Siokal, B., Mappanganro, A., & Asfar, A. (2025). The influence of stunting education using video playback and demonstration methods on the knowledge of mothers with stunted children. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025037>
- Siregar, E. S. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Tumbuh Kembang Balita di Klinik Bidan Novi. *JIDAN: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 1(2), 54-60.
- Sugeng, H. M., Tarigan, R., & Sari, N. M. (2019). Gambaran Tumbuh kembang Anak pada periode emas usia 0-24 bulan di posyandu wilayah kecamatan jatinangor. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 4(3), 96-101.
- Suminar, J. R., Arifin, H. S., Fuady, I., Aisha, S., Moch, A. S. S., & Prasanti, D. (2021). Application of Planned Behavior Model: Factors Affecting Young Mothers' Intention of Behavior in Stunting Prevention in West Java. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 100–

109. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11/5/10>

Susanti, N. Y., & Adawiyah, R. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Stimulasi Perkembangan Anak Dengan Keterampilan Ibu Dalam Melakukan Stimulasi Perkembangan Anak. *Journal for Quality in Women's Health*, 3(1), 67-71.

Syahrul, S., & Nurhafizah, N. (2021). Analisis pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial dan emosional anak usia dini dimasa pandemi corona virus 19. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 683-696.

Tafesse, T., Yoseph, A., Mayiso, K., & Gari, T. (2021). Factors associated with stunting among children aged 6–59 months in Bensa District, Sidama Region, South Ethiopia: unmatched case-control study. *BMC Pediatrics*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-021-03029-9>

Tarmizi, Siti Nadia. 2023. "Prevalensi Stunting Di Indonesia Turun Ke 21,6% Dari 24,4% – Sehat Negeriku." <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> (April 24, 2023).

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2022). The State of the World's Children 2022: Reimagining a better future for every child. UNICEF. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2022>

Vega, A., Hapidin, H., & Karnadi, K. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433-439.

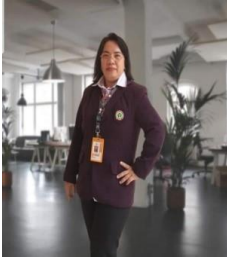
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., Franca, G. V. A., Horton, S., Krusevec, J., Murch, S., & Rollins, N. C. (2021). Achieving the Sustainable Development Goals through breast-feeding: A call to action. *The Lancet*, 397(10292), 285-297. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32284-1
- Vikram, K., & Vanneman, R. (2020). Maternal education and the multidimensionality of child health outcomes in India. *Journal of Biosocial Science*, 52(1), 57-77. <https://doi.org/10.1017/S0021932019000245>
- Wandani, Z. S. A., Sulistyowati, E., & Indria, D. M. (2021). Pengaruh Status Pendidikan, Ekonomi, dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Status Gizi Anak Balita di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jurnal Kedokteran Komunitas (Journal of Community Medicine)*, 9(1).
- WHO. 2015. "Stunting in a Nutshell." World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell> (April 23, 2023).
- Wijayanti, A. R., & Edmiandini, U. F. (2017). Hubungan Sikap Ibu Tentang Stimulasi Perkembangan Dengan Tahap Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia 3-4 Tahun. *Jurnal Kebidanan*, 6(1), 18-25.
- World Health Organization (WHO). (2021). Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240066485>
- Wulandini, P., Efni, M., & Marlita, L. (2020). Description of mother's knowledge who have a toddler about stunting in rejosari health center Tenayan Raya sub district 2019. *CMJ*, 3(1), 8-14.

- Yadika, A. D. N. (2019). Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian Stunting pada balita (usia 24-59 bulan) di wilayah kerja puskesmas Way Urang Kabupaten Lampung Selatan.
- Yunitasari, E., Rahayu, M., & Kurnia, I. D. (2020). The effects of lecture, brainstorming, demonstration (CBD) to mother's knowledge, attitude, and behavior about stunting prevention on toddler. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 1131–1136.
<https://doi.org/10.31838/srp.2020.6.163>
- Zong, X., & Li, M. (2019). Nutritional assessment and management of stunted children. *Pediatric Clinics of North America*, 66(3), 617-633.
doi: 10.1016/j.pcl.2019.02.006

GLOSARIUM

Edukasi	:	Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia
Self effikasi	:	Kepercayaan diri

PROFIL PENULIS



Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns, Sp.Kep.An., lahir di Kalawara 13 April 1975. Lulusan Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Anak Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013. Bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Jurusan Keperawatan.

Sebagai dosen sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 -2018 menjabat sebagai Kaprodi D-III Keperawatan, 2018- sampai sekarang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana terapan Keperawatan Ners. Adapun Buku yang pernah diterbitkan adalah Dukungan keluarga pada Imunisasi Anak, Konsep Keperawatan Anak dan Buku Ajar keperawatan anak 1, pengalaman publikasi internasional dan nasional dalam area keperawatan anak baik pada jurnal bereputasi dan jurnal nasional terkakreditasi sinta. Pengalaman organisasi sebagai anggota perinasia sejak tahun 2012, organisasi IPANI: sebagai bendahara Tahun 2014 -2017, Sebagai Koordinator pendidikan dan pelatihan 2017-2022 dan 2023 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua bidang organisasi, Hukum dan Sistem Informasi. Pengurus AIPNI regional 8 sebagai anggota bidang pendayagunaan lulusan dan Uji Kompetensi tahun 2022 sampai sekarang.

PROFIL PENULIS



Ni Luh Jayanthi Desyani, M.Kep., Ns., Sp.Kep.MB., Lahir di Werdhi Agung, 21 Desember 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sam Ratulangi tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan Ners Spesialis pada Universitas Indonesia

Fakultas Keperawatan dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di Poltekkes Kemenkes Manado hingga saat ini. Penulis saat ini mengampu mata kuliah KMB I dan KMB II. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti, penulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: desya2112@gmail.com



Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes., lahir di Toraja Utara, pada tanggal 06 Oktober 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya meneruskan pendidikan S1 Ilmu Keperawatan dan S2 Ilmu Biomedik (Fisiologi) di Universitas

Hasanuddin. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen tetap di Akper Sandi Karsa Makasar. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado dan sedang mengikuti Pendidikan S3 Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya.

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengkaji pentingnya edukasi sebagai sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas ibu dalam memberikan stimulasi perkembangan anak yang mengalami stunting. Edukasi tidak hanya menjadi alat untuk menambah pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap positif dan meningkatkan rasa percaya diri (self-efikasi) ibu dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh utama.

Melalui pendekatan berbasis penelitian, buku ini menjelaskan bagaimana intervensi edukasi yang dirancang secara terarah dapat memengaruhi kemampuan ibu untuk memahami kebutuhan perkembangan anak serta mengatasi berbagai hambatan yang terkait dengan stunting. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.

Dilengkapi dengan data empiris dan panduan praktis, buku ini ditujukan untuk akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya perbaikan kesehatan dan perkembangan anak. Buku ini menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat peran ibu sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan.

Buku ini mengkaji pentingnya edukasi sebagai sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas ibu dalam memberikan stimulasi perkembangan anak yang mengalami stunting. Edukasi tidak hanya menjadi alat untuk menambah pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap positif dan meningkatkan rasa percaya diri (self-efikasi) ibu dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh utama.

Melalui pendekatan berbasis penelitian, buku ini menjelaskan bagaimana intervensi edukasi yang dirancang secara terarah dapat memengaruhi kemampuan ibu untuk memahami kebutuhan perkembangan anak serta mengatasi berbagai hambatan yang terkait dengan stunting. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.

Dilengkapi dengan data empiris dan panduan praktis, buku ini ditujukan untuk akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya perbaikan kesehatan dan perkembangan anak. Buku ini menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat peran ibu sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

